3. La familia entre la neurosis y la comunicación

Reflexiones históricas sobre psicoanálisis, sistema y estructura

Florencia Adriana Macchioli

Hacia mediados de 1963, un grupo de profesionales en cierto lugar de la provincia de Buenos Aires tuvo lo que parecía una simple idea en sintonía con los aires de la época: describir la neurosis como una modalidad particular de comunicación. Esta búsqueda los llevó prontamente a tener que definir cómo entendían la neurosis y cómo la comunicación, así como explicitar que el grupo familiar indudablemente tenía importantes vínculos con la enfermedad mental, en tanto corolario obligado del vínculo entre individuo y sociedad. En esta dirección, ya había una serie de investigaciones que postulaban conceptos como el "doble vínculo"[1] que ofrecía un modelo de interacción familiar en el que ciertas paradojas producían enfermedad mental, más específicamente, esquizofrenia. Estos profesionales trabajando en el Policlínico de Lanús, entre psicólogos recién recibidos, psiquiatras reformistas y psicoanalistas implicados con lo social, extenderán el modelo de la esquizofrenia a la neurosis aunque, claro está, de un modo bastante peculiar.

Aquí se abre una serie de problemas. En primer término, luego de la segunda guerra (que trae aparejadas importantes innovaciones tecnológicas y científicas de gran impacto en las ciencias sociales) surgen interrogantes asociados a la relación entre individuo y sociedad, así como la distinción entre salud mental y enfermedad mental. Además, estas nuevas zonas de interés plantean un innovador vocabulario para explicar e intervenir en ámbitos que, aunque

1. El doble vínculo consiste básicamente en una modalidad de comunicación donde la persona, haga lo que haga, no puede "ganar", ya que hay distintos niveles lógicos en el mensaje y sólo se puede desarticular esa situación explicitando el nivel lógico implícito, denominado metacomunicación (Bateson *et al*., 1971 [1956]).

no eran desconocidos (como la ya mencionada relación entre el individuo y la sociedad), se intentaba abordar desde los paradigmas que se forjaban hacia mediados del siglo XX. En esta dirección, a pesar de que dicho tópico de interés había producido diversas investigaciones en períodos precedentes, sus resultados no se mostraban del todo satisfactorios para los nuevos problemas que se configuraban luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido, la intervención terapéutica ya no sólo en el individuo sino también en la sociedad, pasaba a ocupar un lugar privilegiado en la agenda de las disciplinas *psi*,[2] a la vez que se redefinían los criterios de salud y enfermedad mental. Y así como se constituyeron diversas tramas originales en las ciencias sociales, la comunicación cobró un rol destacado que halló en el ámbito *psi* ciertos tópicos de indagación de larga data como la esquizofrenia (en clave fundamentalmente kleiniana) y la neurosis (en clave freudiana) a la luz de las nuevos problemas de mitad del siglo XX.

Ahora bien, referirse a la comunicación y a la neurosis particularmente en la Argentina exige una perspectiva histórica que revele los problemas configurados hacia las décadas de 1960 y 1970 que permiten incorporar a la familia como un nuevo objeto de intervención de las disciplinas *psi*. En este sentido, se abordará una serie de cruces heterogéneos que toman por eje a la familia y que de algún modo culminan en el libro *Comunicación y neurosis* (1970) de Eliseo Verón y Carlos Sluzki. Ambos personajes, de gran impacto en el desarrollo de las ciencias sociales en la Argentina, sintetizan en ese volumen un cruce entre cierto tipo de comunicación y cierto modelo de neurosis. El presente análisis pone de relevancia la propuesta psiquiátrica de Sluzki, aunque no puede soslayar el proyecto sociológico de Verón que, como se verá, en varios puntos se tornan indisociables. De hecho, la característica fundamental de sus investigaciones conjuntas indica una concepción que diverge y a la vez hace convivir desarrollos psicoanalíticos, estructuralistas y sistémicos. Podría sostenerse que fue uno de los más acabados intentos por articular tales teorías, al dar cuenta de la constitución de diversas neurosis (histérica, fóbica y obsesivo-compulsiva) en el seno familiar. Sin embargo, como se desarrollará a lo largo de este capítulo, ni la vertiente psicoanalítica local ni la sistémica que se implantaba en el país desde el modelo

2. Se entenderá por disciplinas *psi* aquello que refiera a lo "psicológico" en sentido amplio, para aludir a todo discurso o disciplina que se ocupe de lo psíquico, sin presuponer necesariamente las relaciones de inclusión o exclusión entre psiquiatría, psicoanálisis y psicología (Dagfal, 2009: 28).

norteamericano retomaron estos aportes, que por diversos motivos quedaron olvidados en algún anaquel de las bibliotecas de los 70.[3]

Entonces, ¿por qué focalizar el análisis en este título de 1970 y más específicamente en la figura de Sluzki? Básicamente porque permite mostrar claramente de qué modo pudieron convivir en cierto período el discurso sistémico y el psicoanalítico. Esto coincide, primero, con algunas de las pertenencias institucionales del psiquiatra argentino como el Servicio de Psicopatología del Policlínico Lanús, el Mental Research Institute (MRI) y la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA). Segundo, con su posición en el campo disciplinar en la intersección entre psiquiatría, psicoanálisis y psicología, por una parte, y de la sociología y antropología, por otra. De modo que en el período que aquí se estudia Sluzki ocupó una suerte de posición doble entre 1963 y 1970. Por una parte, halló la teoría sistémica norteamericana en la Argentina, que se ubicó como opuesta al psicoanálisis. Por otra parte, paralelamente cruzó la teoría sistémica inspirada en Gregory Bateson con un psicoanálisis de corte inglés que pondera la figura de Ronald Fairbairn. Allí, tanto la acepción de "estructura" como la de "sistema" presentarán la coexistencia entre la tradición francesa estructuralista y la versión norteamericana de la teoría de los sistemas, en función de los diversos intereses de Verón y Sluzki. En este sentido, el psiquiatra lanusino, a diferencia de los profesionales sistémicos posteriores, abogó durante un breve período por cierta integración entre la perspectiva sistémica y la psicoanalítica, que culminó en *Comunicación y neurosis*.

Este capítulo recorrerá los siguientes aspectos. En principio se presentarán brevemente algunas dimensiones de la coyuntura política, intelectual y disciplinar argentina de los 60 y los 70 emplazando el punto de mira en el Servicio de Psicopatología del Policlínico Lanús, espacio que permite observar a través de su propia lógica institucional qué sucedía en el ámbito disciplinar *psi*. Asimismo, entre los cruces heterogéneos que florecían entre las ciencias sociales

3. La divisoria posterior entre quienes se consideraban "sistémicos" y "psicoanalíticos" dio lugar al mito de que estas dos vertientes jamás habían compartido un pasado común. Más allá de que esto es sostenido por los autores en juego, los profesionales que trazaron una historia de la especialidad no hacen más que reforzar esta versión. Según Juan Carlos Nocetti (2002), habría un modelo "tradicional" representado por Enrique Pichon-Rivière y, a partir de 1970, una discontinuidad que se vería reflejada en dos extremos: "estructuralistas" e "interaccionistas", el primero personificado por Isidoro Berenstein y el segundo por Carlos Sluzki. Esta versión se repite en las historias de la tradición sistémica.

y el psicoanálisis, se introducen dos figuras relevantes para esta investigación, Enrique Pichon-Rivière y David Liberman, que serán parte del elenco del libro de 1970.

En segundo lugar, se indagará la implantación del estructuralismo francés y de la teoría de la comunicación humana norteamericana, a través de las trayectorias de Verón y Sluzki, respectivamente. Para ello se explorarán algunos aspectos de la creación de las carreras de ciencias sociales en la UBA, de políticas editoriales y de circuitos de recepción, fundamentalmente de Claude Lévi-Strauss y Gregory Bateson, de la contraposición en el ámbito *psi* de una reforma psiquiátrica de corte interaccional frente a una psiquiatría asilar y un psicoanálisis ortodoxo planteado por Sluzki (1973), y la distinción entre los conceptos de "sistema" y "estructura", así como su recepción y uso en la Argentina asociado a los tratamientos familiares.

En tercer término, se profundiza la articulación entre neurosis y comunicación planteada por Verón y Sluzki. Se aborda la estructura de conducta histérica, fóbica y obsesiva desde el punto de vista comunicacional. Para ello, se analiza el modo en que se incluyen los aportes psicoanalíticos de Ronald Fairbarn, Enrique Pichon-Rivière y David Liberman, así como el uso de ciertos conceptos clave psicoanalíticos como el "complejo de Edipo" y el "inconsciente" que se reformulan implícitamente en el libro.

Por último, a partir del recorrido realizado, el análisis se sumerge en la composición lograda por Verón y Sluzki entre 1963 y 1970 que concluye en *Comunicación y neurosis*. Allí se plantea que las estructuras de conducta neuróticas son modalidades específicas de comunicación aprendidas en el proceso de socialización, que tiene como protagonista en sus primeros años de vida a la familia. El conflicto para los autores no se centra en la conflictiva edípica freudiana, sino más bien en el proceso de autonomía del individuo.

En suma, Verón y Sluzki realizan una peculiar combinación entre psicoanálisis, estructuralismo y teoría sistémica. Tanto el psicoanálisis inaugurado por Klein, que pone de relieve la relación emocional entre madre e hijo, como la concepción de la teoría de la comunicación humana que abre las perspectivas de la interacción familiar y el estructuralismo que permite fundar las bases inconscientes de la sociedad, insinúan diversos saberes que originan los surcos que suscitarán múltiples exploraciones con distintos niveles de éxito. Sin embargo, varios motivos parecen haber llevado al olvido de *Comunicación y neurosis*. No es probable que fuera por su validación científica (de las más sólidas, por cierto), sino más bien

que los propios avatares del campo disciplinar, social y político hacia principios de 1970, fueron los que decidieron su destino.

Aires de época

Como sostiene Terán (2008: 258), el hcho de que la política haya condicionado la práctica intelectual no significa que haya determinado el contenido de dicha producción, "significa en cambio que la política construyó los rieles, los caminos, o al menos los contornos por los que circularon las ideas". Será desde esta perspectiva la presentación de ciertos eventos, instituciones, publicaciones y personajes para ir dibujando el escenario en el que se produciría la investigación y la publicación de *Comunicación y neurosis*.

El período que va desde 1957 hasta 1966, se enmarca a nivel político con la destitución de Juan Domingo Perón por la autodenominada "revolución libertadora" en 1955, el programa desarrollista de Arturo Frondizi a partir de 1958 y la instauración de la dictadura de Juan Carlos Onganía a partir de 1966. Asimismo, en el plano de la historia intelectual y disciplinar, se produce una significativa renovación social y cultural, que se extendió a las universidades públicas. El programa desarrollista habilitó la creación de diversos organismos e instituciones por parte del Estado, como el Instituto Torcuato Di Tella y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Paralelamente, las universidades a fines de la década de 1950 modernizaron sus planes de estudio y crearon nuevas carreras, entre ellas Psicología, Antropología y Sociología, a la par de la fundación de la editorial universitaria Eudeba en 1958, el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) en 1957, los servicios de psicopatología en hospitales generales como el Lanús (1956), la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) en 1962, o publicaciones de gran impacto como *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina* (editada desde 1954) o la *Revista de Psicología* (desde 1969).

No obstante, para referirse al campo disciplinar *psi* en la Argentina, debe presentarse en primer término cierto despliegue del psicoanálisis que se inició antes de los 60 y que se combinó con los desarrollos posteriores. En esta dirección, como sostiene Vezzetti, el *psicoanálisis* a lo largo del siglo XX ha sido capaz de impactar en disciplinas tan diversas como la medicina, la psicología, la filosofía y las ciencias sociales, entre tantas otras. Particularmente en la Argentina, los caminos de propagación del freudismo se combinaron generalmente con diversos saberes, presentando un paisaje hetero-

géneo. El psicoanálisis en los 60, época de oro para su expansión en la sociedad y la cultura porteña fue, más que un saber técnico, el impulsor de nuevas prácticas. Promueve "una formación discursiva abarcadora, polifónica, con la filosofía y las ciencias sociales y políticas" a la vez que se filtra en la sociedad, avivando los debates públicos y los interrogantes acerca de su función social en períodos de cambio. En este sentido, parece dedicado, más que a una unidad conceptual, a un tipo de "vocación pública" que se extiende en la universidad, espacio privilegiado para el cruce de diversos saberes que contrasta con la jerarquía de la APA y que facilita su derivación a las intenciones de reforma de la sociedad. Éste fue el ámbito que promovió un boom editorial de los saberes *psi* que se integraron a una "trama discursiva renovada: existencialismo, fenomenología, primer estructuralismo, semiología, marxismos". Y si durante aquellos años hubo lo que se llegó a denominar "escuela argentina de psicoanálisis" fue no tanto por su originalidad teórica sino, por su apertura hacia la sociedad, representada principalmente por la figura de Pichon-Rivière (Vezzetti, 2007).

Tal caracterización del psicoanálisis se estableció en el marco de una modernización cultural que se expandió a los círculos académicos, en los que se combinaron lecturas psicoanalíticas y marxistas que profundizaron el cruce entre disciplinas *psi* y ciencias sociales. Una de las primeras producciones en esta dirección fue *Psicoanálisis y dialéctica materialista* (1958) de José Bleger. A la par, su temprana posición como docente en las recién inauguradas carreras de Psicología desde 1959 sería una de las vías fundamentales para el encuentro entre psicología, psicoanálisis y marxismo. Simultáneamente su mentor, Pichon-Rivière, quien desde la década anterior había difundido un psicoanálisis que combinaba los aportes de Melanie Klein, George Mead y Kurt Lewin, realizó en 1958 junto a otros colegas la Experiencia Rosario, a la vez que jugó un importante papel en la difusión del psicoanálisis en la cultura porteña a través de sus diversas participaciones en el Instituto Torcuato Di Tella, sus columnas en *Primera Plana* y su aporte en diversos medios de comunicación.[4]

4. Mucho se ha escrito sobre Pichon-Rivière. Vale aquí solamente destacar que fue uno de los fundadores de la APA en 1942, así como uno de los que más tempranamente incursionó en las prácticas terapéuticas grupales y familiares en el país. Formaría un importante número de profesionales volcados a temáticas sociales y grupales a partir de los 60. Para mayor información véanse Carpintero y Vainer (2004), Dagfal (2009), Fabris (2007), Macchioli (2010a, 2010c), Vezzetti (1996, 2002), Zito Lema (1976).

Poco después, en la década de 1960, Eliseo Verón quedó ubicado como uno de los introductores del estructuralismo francés en la Argentina, a partir de la traducción de *Antropología estructural* de Lévi-Strauss en 1961, publicado por Eudeba en 1968, así como por su libro *Conducta, estructura y comunicación* (1968). Tanto Verón como Oscar Masotta difundieron el pensamiento estructuralista althusseriano y lacaniano, respectivamente, a través de grupos de estudio a los que asistían psicoanalistas y los primeros egresados de la carrera de psicología.[5]

Entretanto, como fue mencionado, desde 1956 comenzaron a funcionar los primeros servicios de psicopatología en hospitales generales. Particularmente el *Lanús* fue uno de los servicios paradigmáticos. Mauricio Goldenberg[6] gana a fines de 1956 el concurso como jefe de Servicio de Psicopatología y, a partir de entonces, tanto su persona como su servicio se constituirían en un mito sobre el que se asentaría la renovación de la salud mental en la Argentina.[7] Fue uno de los principales impulsores del pasaje de los hospitales monovalentes (hospicios) a los hospitales generales, que comenzaron a contar con recursos de avanzada, como consultorios externos, internación, interconsulta, hospitales de día, psicoterapias breves, grupales y familiares (Sluzki, 2006: 472-473).

El Policlínico de Lanús "Dr. Gregorio Aráoz Alfaro", radicado en el cinturón industrial de la provincia de Buenos Aires, había sido inaugurado en 1952 como un edificio de alta complejidad en el marco de los hospitales creados por Ramón Carrillo, ministro de Salud Pública del segundo gobierno de Perón, para ampliar la capacidad asistencial.[8]

5. Para mayor información puede consultarse: Acuña (2009), Carpintero y Vainer (2004), Dagfal (2009).

6. Mauricio Goldenberg (1916-2006) se recibió de médico psiquiatra en 1946, en la Facultad de Medicina (UBA). Desde 1944 su carrera docente fue paralela a su carrera asistencial. En 1950, viajó a París, Inglaterra e Italia, donde se puso en contacto con las ideas de la renovación psiquiátrica de posguerra. Su eclecticismo, con aperturas hacia la psiquiatría clásica, el psicoanálisis y la psiquiatría comunitaria norteamericana, lo llevó rápidamente a incorporarse al movimiento de la salud mental. Para ampliar su biografía, véase Wolfson (2009).

7. Uno de los estudios más minuciosos sobre el tema lo realizó Sergio Visacovsky (2002).

8. Se modificó su nombre original "Hospital Interzonal de Agudos «Evita»" por el de Policlínico "Dr. Gregorio Aráoz Alfaro", por el antiperonismo oficial entre 1956-1973 y 1976-1987 (Visacovsky, 2002: 27).

Entre las estrategias que implementó Goldenberg para aumentar el personal, se rodeó de jóvenes profesionales que, a cambio de formación, trabajaban ad honórem en el Servicio. Uno de los primeros en integrarse fue Carlos Sluzki, a quien le faltaba un año para recibirse. Poco después, Goldenberg lo ubicó como jefe de Investigación, a Hernán Kesselman como jefe de Clínica y Docencia, y a Lía Ricón como jefa de Consultorios Externos.[9]

Hacia 1958 Goldenberg diagnosticó la situación de entonces como un escenario de hospitales llenos, mal atendidos y costosos, que desatendían problemas en la niñez, la adolescencia y los cuadros leves como las neurosis, por lo que proponía para ellos nuevos dispositivos como las psicoterapias, la psicofarmacología, y nuevos contextos a partir de los hospitales generales. Para esto último planteaba una descentralización a partir de la creación de consultorios externos, de servicios de psiquiatría en hospitales generales y de dispensarios (hoy en día, los centros de salud). Todos estos permitirían una fácil accesibilidad por parte de los habitantes mediante tratamientos ambulatorios para no perder contacto con sus familiares, lo que implicaba la no segregación del paciente equiparando la enfermedad mental a cualquier otra que tratara el hospital. La clave aquí era que el enfermo se reintegrase rápidamente al trabajo y a la sociedad. Asimismo, que los psiquiatras se insertaran en un hospital general permitía que esta especialidad se relacionara con la medicina general y con los servicios complementarios de tratamiento e investigación. En este sentido, propuso que en el equipo participaran psicólogos, asistentes sociales y enfermeras psiquiátricas y que los tratamientos pudieran ser tanto biológicos como psicoterapéuticos individuales, grupales y sociales.

Goldenberg utilizó diversas estrategias para llevar adelante sus objetivos, algunos explicitados por él mismo, otros implícitos. Entre ellos: promover una mayor demanda en la población, mejorar la relación de los profesionales del Servicio con el resto de profesionales del Policlínico, promover una asistencia gratuita que poseyera el mismo nivel que la clínica privada, rodearse de jóvenes profesionales para responder a la creciente demanda para los que el Lanús representaba un lugar de progreso social, la combinación entre psiquiatría y psicoanálisis que promovía diversas alianzas y la obtención del

9. Con el tiempo, diversificaron los equipos: Aurora Pérez como jefa de Niños, Octavio Fernández Mouján de Adolescencia, Valentín Barenblit de Interconsulta y Gerardo Stein de Grupos.

apoyo de los sectores de poder para hacerse de distintos recursos (principalmente económicos),[10] a la par de hacer público el Servicio a través de publicaciones, presentaciones a congresos, invitación de personajes renombrados,[11] etc. (Goldenberg, 1982: 163; Carpintero y Vainer, 2004: 98).

Entre los efectos que estas directrices generaron, el servicio pasó de incluir seis a ciento cincuenta personas y el Lanús comenzó a ser visualizado por parte de los primeros psicólogos y estudiantes de la carrera de Psicología como una instancia de inserción en la que los profesionales pasaban a formar parte de los Departamentos y del Gabinete de Psicología (donde se llevaban a cabo los tests). Para Goldenberg, en definitiva, los psicólogos debían insertarse siempre en equipos y su campo de acción se dirigía básicamente, la familia y la niñez (Visacovsky, 2002: 149).

Además, Goldenberg contó con diversas alianzas, incluso de grupos antagónicos en la salud mental. Entre ellas, una de las conexiones predominantes fue con la APA, institución que le suministró docentes, supervisores y hasta un grupo terapéutico para el *staff* coordinado por León Grinberg. A cambio, Goldenberg recomendó una gran cantidad de profesionales del Lanús para que hicieran carrera en la APA. Así, el Lanús fue probablemente "la primera institución –más allá de la APA– en ofrecer una formación clínica integral a partir de una perspectiva psicoanalítica, incluyendo supervisiones, cursos teóricos e investigación [...] se convirtió en una alternativa de peso a la formación de elite propuesta por la APA, que sólo era accesible para unos pocos médicos. El trabajo en el hospital, aunque mal remunerado, implicaba un lugar cierto para formarse y que podía complementarse con grupos de estudio privado" (Dagfal, 2009: 300). Paralelamente, colaboró con autoridades de diferentes gobiernos y mantuvo durante un largo período relaciones con la OMS. Esta imbricación tan particular entre el psicoanálisis y el resto de las

10. En esta dirección, si se retoma la denominación del hospital (primero "Evita", luego "Aráoz Alfaro"), la operación de sustitución de ambas denominaciones por "el Lanús" evita las oscilaciones que representaba cada uno de los nombres donde acepta, por una parte, la proscripción del peronismo, pero por otra, no reconoce la nueva denominación impuesta por el gobierno militar (Visacovsky, 2002: 109).

11. Incluso visitaron el servicio figuras de nivel internacional como Maxwell Jones y David Cooper cuando estuvieron en la Argentina (Visacovsky, 2002: 161; Carpintero y Vainer, 2004: 101). Jones visitó dos veces la Argentina a mediados de los 60 (Carpintero y Vainer, 2004: 281), Cooper estuvo en 1970 y 1972, cuando se instaló en la Argentina durante algunos años (Carpintero y Vainer, 2005: 173).

orientaciones psiquiátricas y psicológicas es lo que probablemente le confiere su sesgo distintivo, a la vez que afirmaba al psicoanálisis como su núcleo y sostén identitario.[12]

Asimismo, el objetivo de hacer público el Servicio se consiguió en pocos años. Tanto Kesselmann como Sluzki fueron secretarios de Redacción de *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*. De hecho, las investigaciones de Sluzki tuvieron lugar en el Lanús y se difundieron a través de *Acta*. Esta gran visibilidad del Servicio llevó a que concurriera no sólo población de diversos lugares, sino también estudiantes y profesionales con intenciones de realizar una psicoterapia psicoanalítica sin recursos económicos para costearla, llegando de esta manera el prestigio del Lanús a los sectores medios.

A mediados de 1967 Goldenberg se hace cargo del Departamento de Salud Mental de la Capital Federal, en pleno gobierno de Juan Carlos Onganía.[13] En el mismo año, es nombrado Julio Ricardo Estévez[14] como interventor del INSM y formula un amplio Plan de Salud Mental a partir del cual, según los lineamientos de la OMS de 1963, se crean comunidades terapéuticas dentro de los hospicios y las colonias del país.[15] Para ello, convocan a Goldenberg.[16] En 1968, es nombrado jefe del Departamento de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires hasta 1971, momento en el que también es desplazado

12. Desde la perspectiva de los "lanusinos", el Servicio "no fue clasificado como una anomalía a caballo entre psiquiatría y psicoanálisis, sino un estilo, un «estilo psicoanalítico» […] La ambigüedad referida a la relación con el psicoanálisis no fue interpretada como un problema, sino como un valor" (Visacovsky, 2002: 121).

13. Durante "La noche de los bastones largos", varios miembros del staff del Lanús debieron escapar por las ventanas de la facultad para evitar golpes y detenciones. Esto llevó a una renuncia masiva de profesores a la universidad, aunque la Facultad de Medicina no fue de las más combativas. Goldenberg fue uno de los pocos que renunció junto con su equipo (Wolfson, 2009: 90).

14. Personaje implicado durante la última dictadura en las torturas y las desapariciones del Hospital Posadas.

15. Tanto el impacto del gobierno de Onganía, como de la última dictadura militar en la salud mental argentina, fue desarrollado por Carpintero y Vainer (2005). Allí se relatan los avatares de algunas de las comunidades terapéuticas inauguradas a partir de 1967.

16. Este proceder llevó a varias críticas de sus allegados por entenderse como una actitud de colaboración con la dictadura militar. Goldenberg no quería cobrar, pero como la estructura administrativa no admitía un jefe no rentado, se convino un sueldo simbólico de un peso. A cambio, Goldenberg requirió no ser censurado en sus resoluciones, como la de modernizar el sistema de salud mental de la Capital.

Estévez. En este período, las relaciones con la APA siguen siendo prolíficas, y los psicoanalistas de este núcleo continúan alimentando de docencia y supervisión ad honórem a los nuevos servicios, aunque ya se anunciaban diversos sectores en el interior de la asociación que desembocarían en la primera ruptura en la APA de los grupos Plataforma y Documento en noviembre de 1971 (Carpintero y Vainer, 2005; Vezzetti, 2009).

A partir de aquí comienza la sucesión de diversas trabas. La Dirección de Salud Mental de la Ciudad de la Capital Federal se expande demasiado y otros departamentos comienzan a presentar objeciones, los equipos contratados para hacer prevención primaria en villas de emergencia de la ciudad trabajan varios meses sin que nunca lleguen los contratos y los proyectos de Hospital de Noche y Casas de Medio Camino no cuentan con presupuesto. Todo esto, sumado a que el país estaba ya en el marco de una dictadura que imponía sus límites a la modernización del ámbito *psi*. En este contexto, en 1969 el Cordobazo generaría diversos efectos, entre ellos la debilitación y la posterior destitución del gobierno de Onganía.

Paralelamente, en 1971 Goldenberg gana el concurso para jefe de Servicio en el Hospital Italiano y en 1972 deja el Lanús. Este pasaje no sólo implicaba dejar un hospital por otro, sino pasar de un hospital público a uno privado, situación que se reproduce en muchos profesionales durante la década de 1970.[17]

Este sucinto recorrido permite entrever cierta matriz intelectual que habilitaba cruces heterogéneos entre ciencias sociales y psicoanálisis, cruces que se remontan a los primeros debates acerca del rol del psicólogo en los tempranos 60 centrados en gran medida alrededor de la figura de Pichon-Rivière y su tránsito "del psicoanálisis a la psicología social" (Vezzetti, 2004: 294). Cabe recordar que era psiquiatra, fundador de la APA y que formó a las primeras camadas de psicólogos fundamentalmente a través de uno de sus principales discípulos: José Bleger. Y desde luego, las nuevas matrices conlleva-

17. Respecto de los profesionales que atendían familias, el desplazamiento de los ámbitos públicos a los privados puede rastrearse en el período que va desde 1968 hasta 1972. Solo basta mencionar que Sluzki del Servicio de Psicopatología del Lanús, emigró en 1971 a Estados Unidos donde se incorporó al staff del MRI; que Isidoro Berenstein dejó el hospital Rawson y la Fundación Acta Fondo para la Salud Mental, para permanecer solamente en la APA hasta 1977 y posteriormente en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APDEBA) y la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo (AAPPG), y que García Badaracco pasó del Hospital Neuropsiquiátrico de Buenos Aires (actual hospital "José T. Borda", el mismo hospicio en el que había estado Pichon) a fundar la clínica privada DITEM.

ron diversos saberes y prácticas que redefinieron la psicopatología de la época.

En el escenario descripto, pueden hallarse diversas articulaciones. En esta dirección, así como se mencionó a Pichon-Rivière, quien creó un modelo que ensamblaba psicoanálisis kleiniano, Gestalt y dinámica grupal (entre otros saberes), pueden ubicarse otros tantos profesionales que exploraron diversas intersecciones. Tal es el caso de David Liberman (1920-1983). Nacido en Buenos Aires, se recibió de médico psiquiatra y posteriormente se incorporó a la APA, representando a la segunda generación de psicoanalistas, para pasar posteriormente a ser uno de los miembros fundadores de APDEBA en 1977 (segunda institución, luego de la APA, con el aval de la Asociación Psicoanalítica Internacional). Pichon-Rivière fue su analista y maestro. Entre sus intereses, se observa un primer período en el que investiga la clínica psicopatológica y las dificultades que presenta en el proceso psicoanalítico. Más tarde incorpora el modelo comunicacional a su perspectiva psicoanalítica, a partir de aportes de la teoría de la comunicación de Jürgen Ruesch, de la lingüística de Noam Chomsky (de quien toma el modelo de la gramática generativa) y el modelo de Roman Jakobson sobre factores y funciones de la comunicación para formular su modelo de los "estilos" comunicacionales. Estos desarrollos tomaron cuerpo a partir de la publicación de *La comunicación en terapéutica psicoanalítica* (1962). Allí articuló los principios básicos del psicoanálisis (libido, inconsciente, transferencia) a la teoría de la comunicación. Liberman encabeza el libro con un apartado dedicado a la teoría de la comunicación y las teorías psicoanalíticas de la neurosis, donde traza un maridaje entre la clasificación de tipos patológicos de Ruesch (1957) con la nomenclatura psicoanalítica de Otto Fenichel (1957), para la que establece sintéticamente algunas de las siguientes equivalencias: la persona "demostrativa", "atemorizada y huidiza" y "lógica" de Ruesch, corresponde al carácter histérico, fóbico y obsesivo de Fenichel, respectivamente. Sin embargo, Liberman sumará a los aportes de ambos autores la perspectiva psicoanalítica inglesa al incorporar al análisis las fantasías inconscientes, las relaciones objetales y las ansiedades básicas. Esta clasificación será retomada en *Comunicación y neurosis*.[18]

18. Entre otras de las principales obras de Liberman, se encuentran *Lingüística, interacción comunicativa y proceso psicoanalítico*, 3 t., Buenos Aires, Nueva Visión, 1972; *Comunicación y psicoanálisis*, Buenos Aires, Alex Editor, 1976; D. Liberman y D. Maldavsky, *Psicoanálisis y semiótica*, Buenos Aires, Paidós, 1975. Hoy su obra es continuada por David Maldavsky.

De hecho, Verón y Sluzki se proponían desde 1963 articular al individuo y la sociedad, la comunicación y la neurosis en un escenario que, como se ha descripto, alentaba y estimulaba diversas combinaciones de saberes. La teoría de los sistemas norteamericana, además de no explicar la nosografía psiquiátrica, prácticamente se oponía a ella en tanto se posicionaba como una nueva clave para entender y tratar la enfermedad mental desde la interacción. En este sentido, a pesar de que Sluzki se entrenó en el MRI en 1965 y fue el principal difusor de esta corriente en la Argentina, continuó paralelamente investigando los procesos comunicacionales en la neurosis y su posible etiología en clave interaccional. Y, en este sentido, el psiquiatra lanusino ocupó una posición en el campo disciplinar bastante excepcional. Su formación y temprana inserción en el campo psiquiátrico reformista de cara a lo social se combinó con la difusión del psicoanálisis kleiniano de la cultura local, en el que Sluzki recepcionó y difundió los desarrollos interaccionales norteamericanos. A caballo entre el sur y el norte, Sluzki, más allá de su lugar de residencia (hasta 1971 en la Argentina, luego en Estados Unidos), jugó un papel de embajador en ambos campos disciplinares. Mientras que aquí era el representante de la teoría de la comunicación humana y el interaccionismo, en Estados Unidos puso en contacto el Lanús con el MRI a partir de 1965, intercambio que originó fructíferos desarrollos en ambas sedes del pensamiento interaccional casi simultáneamente. Sin embargo, otro personaje protagónico debe entrar en escena para desarrollar el particular y original planteo de *Comunicación y neurosis*: Eliseo Verón.

De Norteamérica a la Argentina vía Francia

Desde el abordaje historiográfico planteado, se desprende que destacar un perfil biográfico parte del supuesto de que las figuras individuales en la conformación de un nuevo dominio representan las condiciones de posibilidad de un determinado momento histórico. La mayoría de las veces, tales representantes poseen una sensibilidad, un intelecto y/o una posición en el campo disciplinar particular para destacarse entre el resto de profesionales, pero sólo pueden adquirir visibilidad, audiencia y reconocimiento gracias a las circunstancias específicas de la sociedad y del campo científico en un momento determinado.

En esta dirección, se trazará primero una breve reseña de Verón y Sluzki para luego hacer una sucinta presentación de la recepción

del estructuralismo francés en la Argentina. Algunas cuestiones se dejarán solamente señaladas aquí, como la caracterización de la implantación del estructuralismo, su relación con las ciencias sociales y la apertura de carreras afines a esta orientación (Sociología, Antropología y Psicología, entre ellas).

Eliseo Verón nació en 1935 en Buenos Aires, se recibió en 1961 como licenciado en Filosofía, UBA, y obtuvo una beca del Conicet para estudiar en el Laboratorio de Antropología Social del Collège de France junto a Claude Lévi-Strauss. En 1962, a partir de un seminario que cursó con Roland Barthes en la École Pratique des Hautes Études, se contactó con la semiología saussuriana. Estuvo a cargo de la primera traducción al castellano de *Antropología estructural* en 1968, obra que prologa. En la Argentina fue profesor del Departamento de Sociología, UBA, y dirigió el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Di Tella entre 1967 y 1968. En 1970 obtuvo la beca Guggenheim y se radicó en Francia hasta 1995.

Sus trabajos, ya desde la década de 1960, son referentes ineludibles tanto a nivel nacional como internacional. Entre las obras principales del período pueden citarse: *Conducta, estructura y comunicación* (1968), el prólogo mencionado de *Antropología estructural* (1968), el libro al que se dedica este trabajo, *Comunicación y neurosis* (1970), y *Lenguaje y comunicación social* (1971). Particularmente este último, compilado por Verón, reúne distintos trabajos presentados en un simposio sobre teoría de la comunicación y modelos lingüísticos en ciencias sociales realizado en Buenos Aires en octubre de 1967. Entre los discutidores de aquel simposio se encontraba Liberman, y entre los expositores Luis Prieto, Oscar Masotta, Paul Ekman y Carlos Sluzki. Verón presentó "Hacia una ciencia de la comunicación social", mientras que Sluzki se ocupó de las "Estructuras semánticas y contratransferencia". Allí, el psiquiatra argentino muestra un gran conocimiento sobre los autores psicoanalíticos que abordaron la cuestión, a la vez que lo pone en relación con varias líneas de investigación alrededor de la neurosis que se incluirán en el libro de 1970, como se verá más adelante.

Por su parte, Carlos Sluzki nació en la Argentina, cursó la carrera de Medicina en la UBA, de la que egresó en 1960. Como estudiante participó en la organización y la dirección de la Comisión Universitaria de Solidaridad entre 1953 y 1955 (una organización de derechos humanos que tenía por finalidad ayudar a los estudiantes que fueron presos políticos de los gobiernos de ese período, que coincide con los últimos años del segundo mandato de Perón). Pocos años después, desarrolló y condujo un programa de preparación psicoedu-

cativa para mujeres embarazadas y sus parejas en 1956, el primero de su tipo que funcionó en un hospital público argentino (Sluzki, 1996: 104). Siendo todavía estudiante, se unió en 1957 al equipo del Policlínico Aráoz Alfaro dirigido por Mauricio Goldenberg. Allí se desempeñó en distintos puestos hasta convertirse en 1967 en director del Centro de Investigaciones Psiquiátricas y director asociado del Departamento de Psicopatología.

Entretanto, Sluzki llevó a cabo su formación y entrenamiento psicoanalítico en la APA hasta 1967 y en 1965 se incorporó al Comité de Redacción de *Acta Psiquiátrica de América Latina*. En 1971, se mudó definitivamente con su familia a Estados Unidos, un año después de que Verón se radicara en Francia. Entre sus publicaciones, de sus más de cien artículos, los primeros treinta fueron escritos en la Argentina durante los años que se analizan a continuación, y la mitad de sus quince libros se editó en su país de origen antes de 1975.

No obstante, desde inicios de la década de 1960 se incorporó paralelamente a un equipo de investigación dirigido por Eliseo Verón. Este vínculo inauguró un cruce muy particular y prolífico en los años subsiguientes entre psiquiatría y sociología.

Para echar luz a la compleja trama histórica en la que se encuentran Verón y Sluzki hace falta hacer un rodeo por el estructuralismo.[19] Este movimiento intelectual tuvo su auge en las ciencias sociales entre las décadas de 1950 y 1960 fundamentalmente en Francia. Más allá de sus características singulares, su implantación en la Argentina durante los 60 parece haber destacado su uso, según Cynthia Acuña (2009) más como una herramienta de interpretación y de crítica ideológica en ciencias sociales que como una filosofía o un método al modo francés. En esa dirección, el estructuralismo fue un tipo de "semiología aplicada a la sociología, la crítica literaria, la arquitectura, el arte pop o la psicología" (131) y no un método estructural análogo al de la lingüística o la antropología.

Acerca de la recepción del estructuralismo en el nivel local, se presentarán aquí a modo introductorio lo que se describió como tres momentos de implantación.[20] La primera etapa se ubica a comienzos de la década de 1960 fundamentalmente en el Departamento de Sociología (UBA), en el marco de la institucionalización de una

19. Para mayor información, véase Dosse (2004).

20. Para la recepción del estructuralismo en la Argentina, se seguirá el análisis de Acuña (2009).

sociología científica representada por Gino Germani, cuando se configura una metodología de investigación "con pretensión científica" en ciencias sociales. Aquí pude ubicarse la transmisión académica del estructuralismo francés (entre ellos, Lévi-Strauss y Barthes) a cargo de Eliseo Verón, entre 1963 y 1966. La segunda, se sitúa hacia mediados de los años 60, cuando el estructuralismo se amplía al añadir nociones ajenas a la tradición francesa y continúa extendiéndose más allá del ámbito académico, utilizándose como una "herramienta de interpretación". Por último, hacia fines de la década de 1960, dicha trama discursiva empieza a diferenciarse, al mismo tiempo que el psicoanálisis de impronta lacaniana configura espacios de producción que se dirigen a su institucionalización (a partir de congresos, traducciones de las obras de Lacan, la publicación *Cuadernos Sigmund Freud*, la Fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, etcétera).

También, pueden situarse tres momentos de difusión editorial del estructuralismo que se superponen a la periodización anterior. El primero, entre 1958 y 1964, de recepción y transmisión fundamentalmente en lengua francesa. El segundo, entre 1964 y 1970, de difusión ampliada, en el que predominan las traducciones. Y el tercero, a partir de 1970, de implantación, en el que sobresale la producción local. De este modo, la traducción de títulos sobre estructuralismo en la Argentina inicia su curva ascendente a mediados de los 60, aunque previamente pueden hallarse algunas traducciones.[21] Es interesante plantear aquí una breve reseña del panorama editorial de aquellos años.

Por una parte, *Nueva Visión*, fundada en 1951 por Tomás Maldonado, inició como una revista trimestral de gran impacto en el ámbito de la arquitectura durante los 50, que derivó luego en la apertura de la editorial Nueva Visión. Se ocupó de editar títulos asociados las ciencias sociales y el arte. Hacia 1969, en su catálogo incluye varios títulos sobre estructuralismo y semiología. La primera colección la dirigió Oscar Masotta e incluyó títulos fundamentales sobre el tema, como el mencionado *Lenguaje y comunicación social* (1971). Otra de sus colecciones, "El pensamiento estructuralista", dirigida por José Sazbón desde 1969, será pro-

21. Por ejemplo, en publicaciones como los *Cuadernos* del Instituto de Sociología del Departamento de Sociología (UBA) cuando aparece una traducción de Lévi-Strauss en 1959 o, poco después, en 1962 cuando se publica en *Cuestiones de Filosofía* un reportaje a Lévi-Strauss realizado por Verón, "La antropología hoy: una entrevista a Claude Lévi-Strauss" (Acuña, 2009: 62).

bablemente una de las colecciones más importantes sobre el tema editada en la Argentina (Acuña, 2009: 64).

Otro caso es el de Eudeba, la editorial de la UBA, fundada en 1958. Su primera etapa (1958-1966) estuvo dirigida por Boris Spivacow (De Sagastizábal, 1995: 142). En 1959 se publicaron los primeros títulos de la editorial que, aunque estaban dirigidos a un público universitario, también impulsaban una difusión masiva. Es así como Eudeba llegó a publicar entre 1958 y 1966 más de ochocientos títulos. La traducción de *Antropología estructural* se inscribe como uno más de los títulos de este proyecto editorial.

La Fundación Di Tella organizó en 1958 el Instituto Di Tella dedicado a la investigación cultural. Hacia 1960 ya funcionaba el Centro de Investigaciones Económicas y el Centro de Arte. Entre 1965 y 1970 alcanzó su máximo reconocimiento como representante de las vanguardias artísticas del momento en el país. Además de teatro, música y pintura, entre otras artes, el centro se dedicó a la investigación social incluyendo en su seno diversas ciencias sociales. El Instituto cerró en 1970 en el marco del gobierno de Onganía, por lo que parece ser una conjunción de factores políticos y económicos.[22] Sobre la Editorial del Instituto puede rastrearse uno de sus primeros títulos en 1963, una compilación de *Poesía argentina*, en el que participan autores como Raúl Gustavo Aguirre, Rodolfo Alonso, Edgar Bayley, Olga Orozco o Aldo Pellegrini; a pesar de que la Fundación cierra en 1970, la editorial continúa editando libros hasta avanzada esa década.[23] En este escenario, la edición del libro de Verón y Sluzki poco después de que se cerrara el Instituto puede haber sido otro de los tantos factores que incidieron en su escasa circulación.

Ahora bien, si se pone el foco en la primera etapa de la difusión del estructuralismo, puede rastrearse que el primer ámbito en el que se recibe esta corriente fue el Departamento de Sociología (UBA) creado en 1957, que encuentra su figura principal en Eliseo Verón. En aquel momento era estudiante de filosofía y comenzaba su carrera como ayudante de cátedra. En 1958 se incluirá por primera vez a Lévi-Strauss en un programa de Sociología Sistemática (cuyo titular era Gino Germani) en la carrera de Sociología. Con el

22. La Fundación dependía de la empresa Di Tella, reconocido fabricante de electrodomésticos que también incursionó en la industria automotriz. Tanto los problemas económicos de la empresa como la situación política del gobierno de facto parecen haber incidido en el cierre (Rougier y Schvarzer, 2006).

23. Por ejemplo, se edita Ezequiel Gallo, *Colonos en armas. Las revoluciones radicales en la provincia de Santa Fe*, Buenos Aires, Editorial del Instituto Di Tella, 1977.

posgrado con Lévi-Strauss mediante (París, 1961), será recién en 1963 cuando el autor pasará de ser sólo una referencia en el programa académico para transformarse en un texto leído y discutido por los alumnos. Esto coincide con los cursos que dicta Verón en el Departamento de Sociología entre 1963 y 1966, "Elementos de Metodología Estructural y Construcción de Modelos en Ciencias Sociales (I)" y "Elementos de Metodología Estructural (II): Problemas de Investigación". En dichas materias se desarrollaban los temas que Eliseo Verón, junto con Carlos Sluzki, Ricardo Malfé y Analía Kornblit estaban investigando, con bibliografía de corte estructuralista y de la teoría de la comunicación humana (Acuña, 2009: 74-75). Entretanto, en 1964 Eliseo Verón y Miguel Murmis quedarán a cargo del dictado de Sociología Sistemática, espacio en el que el estructuralismo del antropólogo francés iniciará una difusión ascendente. Allí se incluirá la traducción al castellano de *Antropología estructural*.

En este marco se inician las investigaciones que darán lugar a *Comunicación y neurosis*. Después de su regreso de París, Verón publica una serie de artículos que abren el diálogo entre sociología y psicología desde el abordaje estructuralista en el marco del proyecto de investigación,[24] cuestión que se retomará luego. Y, aunque en 1966 Verón deja la materia Sociología Sistemática y tras él se retira la referencia de Lévi-Strauss en el programa, a partir de 1964 tal perspectiva metodológica cobrará forma en la investigación de Verón y Sluzki.

Sin embargo, así como Verón fue uno de los primeros en introducir a Lévi-Strauss en la Argentina, también fue uno de los primeros que se encontró con Bateson. Este encuentro conllevó, entre otras cuestiones, el desarrollo de una concepción estructural para la psiquiatría social en la que combina a Saussure con Bateson, para arribar a la formulación de las "estructuras de conducta". Así, el "sistema de la lengua", entendido como el sistema de relaciones lógicas entre signos al que se denomina "estructura", más el "deuteroaprendizaje", que refiere al aprendizaje que se adquiere de la propia situación en que se aprende, da por resultado las "estructuras de conducta", es decir, las configuraciones típicas de respuestas ante situaciones, personas o cosas, aprendidas por el individuo en el cur-

24. Como los artículos que publicará en *Acta*: "Notas para una concepción estructural en psiquiatría social", "Estructuras de conducta y sistemas de comunicación social" en 1963 y al año siguiente "Comunicación y trastornos mentales: el aprendizaje de estructuras".

so de su socialización (Verón *et al*., 1963: 302). Las implicancias de las estructuras de conducta con relación al grupo familiar se abordarán más adelante, pero cabe aquí apuntar que la investigación dirigida por Verón desde 1963 que desembocó en la publicación de *Comunicación y neurosis* (1970) nunca dejó de lado la idea de inconsciente, inherente a la concepción de "neurosis" que predominaba en el campo *psi* argentino. E incluso, es altamente probable que el pasaje de Sluzki por la APA incidiera en las bases psicoanalíticas de la investigación, como puede rastrearse en su capítulo "Estructuras semánticas y contratransferencia" incluido en *Lenguaje y comunicación social* (1971).

No obstante, cierto relato histórico (que casi se ha transformado en mito) sostiene que Sluzki, inserto en el grupo interdisciplinario dirigido por Verón en el Instituto de Sociología, halló por casualidad a Bateson y la primera literatura sobre terapia familiar (Sluzki, 1998: 20). El encuentro con la línea cibernético-interaccional podría ubicarse alrededor de 1962 cuando, de modo fortuito, revisando bibliografía para el proyecto de Verón sobre la relación individuo-sociedad (más específicamente sobre correlación social y prevalencias psicopatológicas) halló una revista desconocida para él, *Behavioral Sciences*, en la que estaba publicado el artículo "Toward a theory of schizophrenia" de 1956, traducido al castellano como "Hacia una teoría de la esquizofrenia" (Bateson *et al*., 1971). A partir de dicho escrito comenzó a indagar la producción de los coautores: Gregory Bateson, Don Jackson, Jay Haley y John Weakland. Le escribió a Jackson al poco tiempo (director de la institución en aquel momento) y en 1965 consiguió una beca de tres meses para formarse en el MRI, en Palo Alto, California. Allí entró en contacto con figuras clave de lo que sería la corriente sistémica: Gregory Bateson, Jay Haley, Virginia Satir, John Weakland, Albert Scheflen y los tres autores de *Pragmatics of human Communication*: Janet Beavin, Paul Watzlawick y Don Jackson. A partir de ese momento, Sluzki alternó entre la Argentina y Estados Unidos, y fue nombrado Research Associate en el MRI, cargo que ejerció desde 1965 a 1983.[25] No obstante, no hay que perder de vista que el encuentro "fortuito" se dio en el marco de un proyecto interdisciplinario incluido en la flamante carrera de Sociología, dirigida por uno de los más reconocidos introductores del estructuralismo en la Argentina.

25. Durante ese período en 1978 fue director de Entrenamiento y de 1980 a 1983 de la institución.

Entre los aspectos más innovadores que Sluzki produjo en el campo disciplinar local, se encuentra su propuesta acerca de una reforma psiquiátrica a partir del enfoque interaccional. Para ello, planteó una fuerte crítica no sólo a la institución asistencial psiquiátrica, sino también a la ortodoxia psicoanalítica, para lo cual presentó los ejes con los que pensaba la enfermedad, la clínica, la familia, la institución y el rol profesional del psiquiatra (Sluzki, 1973).

En primer lugar, acerca del eje salud-enfermedad, el psiquiatra lanusino sostiene que, frente al rol de "enfermo mental", se halla el rol complementario de "sano o no enfermo mental". Estos roles se refuerzan mutuamente, por tanto, cualquier modificación que encare una institución asistencial sobre la definición de "paciente psiquiátrico" modificará a sus usuarios y a la institución misma.

El segundo eje plantea una fuerte crítica no sólo a la psiquiatría tradicional, sino fundamentalmente a la psiquiatría dinámica. Ésta, a través de sus propios modelos sobre la salud-enfermedad, refuerza una posición de "sujeto víctima" en el paciente a partir de teorías patogénicas que se basan en la infancia del sujeto para explicar su patología actual, situación que deriva en que el paciente continúe utilizando un programa estereotipado para adecuarse a la realidad.[26] Y así, el terapeuta, al adjudicar un rótulo diagnóstico, termina por reforzar una concepción alienada de la patología del paciente. Es decir, en contraposición al "modelo victimista" psicoanalítico, Sluzki propone el enfoque interaccional. Y a pesar de que este modelo posee una "historia corta" en comparación al psicoanalítico, Sluzki (1973: 74) apuesta a que, "a largo plazo, el enfoque interaccional y el intrapersonal puedan lograr un matrimonio exitoso. Pero, si se quiere evitar el riesgo de un pegoteamiento simbiótico, de una mezcolanza ecléctica, se debe esperar a que cada una de las orientaciones desarrolle su propia identidad por separado, detecte sus alcances y límites, y pueda recién entonces enriquecerse realmente con los aportes de la otra, negociando buenamente las mutuas jurisdicciones".

Sin embargo, pasar de un modelo victimista a uno interaccional obliga necesariamente a replantear los "esquemas referenciales" de la institución asistencial y de los profesionales, cuestión que conllevará obviamente resistencias ya que implica redefinir fundamentalmente la oposición enfermo mental/no enfermo mental (teniendo en

26. Con todo, Sluzki se encarga de aclarar que coincide con el esquema etiopatogénico del psicoanálisis en términos generales, pero no acuerda con el modo en que es utilizado por los profesionales, a pesar de ser la concepción que "se aloja en la base de la mayor parte de las concepciones psiquiátricas en vigencia" (Sluzki, 1973: 73).

cuenta que este último incluye al medio familiar y social que consulta por el "paciente"). La principal crítica de Sluzki respecto de esta cuestión es hacia el rol del "diagnosticador", quien desde una posición de poder rotula los roles de sano-enfermo. Aquí se abre otra serie de problemas alrededor de los valores de los profesionales no tratado aquí, que inciden en gran medida respecto a qué o quién es rotulado como sano o enfermo, normal o anormal.

El tercer eje planteado por Sluzki se basa en la terapia familiar, que se desprende del enfoque interaccional. Partir de la familia y no del sujeto plantea premisas totalmente novedosas sobre "las ciencias de la conducta", que afectan claramente las concepciones mismas de salud y enfermedad. De hecho, en la elaboración del diagnóstico es donde se encuentran las mayores divergencias entre el enfoque individual y familiar. En este último, el síntoma se entiende desde su carácter adaptativo, por tanto, qué situación provoca esa adaptación. Desde esta perspectiva, como las conductas se afectan mutuamente, es arbitrario atribuir una causalidad lineal a alguno de los procesos en desmedro de otros. La inclusión de la terapia familiar para el enfoque interaccional supone revalorizar el contexto del sujeto sintomático, a la vez que permite observar sus secuencias interactivas, incluir la capacidad de creatividad y receptividad del terapeuta, poner en tela de juicio el rol adjudicado por el paciente o su familia y el rol asumido por el terapeuta.

Concluye que "cada institución asistencial refleja en su estructura las características de los esquemas referenciales que la rigen" (Sluzki, 1973: 85), primera alusión a Pichon-Rivière y su esquema referencial. Y continúa Sluzki: la "psiquiatría represiva" posee instituciones con grandes sectores de internación y consultorios externos reducidos. Por su parte, la "psiquiatría dinámica" posee instituciones con grandes consultorios externos, que provee de psicoterapia generalmente individual, con un lapso máximo poco claro y sectores de internación reducidos. En contraposición, el modelo interaccional, situacional y de crisis jerarquiza el primer contacto con el consultante, en el que la recepción se transforma en una etapa que tiene por objetivo predominante una función terapéutica, además de diagnóstica; de tal modo que Sluzki sostiene que la llegada del sujeto a la consulta solo o acompañado provee información sobre la situación del consultante, sumamente útil para operar desde el enfoque interaccional. Segunda alusión a Pichon, que casi treinta años antes en los consultorios del Hospicio de las Mercedes (actual Hospital "José T. Borda") sostenía la misma importancia respecto del modo en que acudía el paciente a la admisión, pero asociado a cierta con-

cepción de dinámica grupal empleada para la familia, para la cual lo social jugaba un papel preponderante, aunque allí lo "social" remitía a otras zonas de saberes y prácticas (Macchioli, 2010a, 2012b).

La afirmación de que cada institución asistencial refleja los esquemas referenciales que la gobiernan, dirige la crítica tanto a la psiquiatría dinámica como a la alienista. En esa dirección, varias historias de las disciplinas *psi* han mostrado diferentes disputas en el campo disciplinar, básicamente entre las tendencias más conservadoras y las más reformistas. Entre estas últimas, puede ubicarse desde fines de los 50 hasta la actualidad el movimiento de salud mental a nivel local.[27]

En este sentido, Sluzki esboza en 1973 su esperanza de que a futuro el enfoque interaccional pueda complementarse con el psicoanalítico, para lo cual hace falta que cada orientación desarrolle su propia identidad y conozca sus propios límites, para así enriquecerse posteriormente ambas "negociando buenamente las mutuas jurisdicciones". Sin embargo, aunque este carácter integrador promovía efectos, como puede observarse en los cruces de saberes y usos presentes en diversas producciones de aquellos años, era poco tenido en cuenta por la mayoría de los profesionales, y fue sistemáticamente invisibilizado por las historias que narran la especialidad en el nivel local.[28]

Ahora bien, para tratar la recepción de la teoría de los sistemas norteamericana conviene trazar primero ciertas distinciones. La teoría de la comunicación humana, la teoría sistémica, la terapia sistémica y la terapia familiar han sido tratadas en la Argentina numerosas veces como sinónimos, a la vez que se las ha opuesto categóricamente al psicoanálisis. No obstante, si se analizan detenidamente los orígenes de estos aportes en distintas latitudes, el escenario que puede deducirse es el siguiente.

Al partir de los primeros desarrollos norteamericanos sobre esta área pueden localizarse, en primer lugar, los intereses de Bateson por estudiar la naturaleza y los niveles de la comunicación. A partir de 1952, cuenta con un equipo de investigación conformado por John Weakland, Jay Haley y William Fry (el único médico psiquiatra del

27. Entre las historias que profundizan en esta cuestión, pueden consultarse: Carpintero y Vainer (2004, 2005), Dagfal (2009) y Plotkin (2003).

28. En este sentido, las historias de la terapia familiar en la Argentina tienden más a marcar las diferencias entre el enfoque psicoanalítico y el sistémico, que a poner de relieve los espacios de diálogo e integración entre ambos (Macchioli, 2010d).

grupo) y dedicado a investigar la comunicación ambigua, que lleva al receptor a una posición paradójica. Con este objetivo estudian los niveles de comunicación en esquizofrénicos, que por sus características particulares presentan una comunicación rica en confusiones de niveles y paradojas, en la que difícilmente se distingue entre metamensajes, contexto, metáforas y literalidad. Estos resultados le permiten al grupo delinear una teoría de la comunicación esquizofrénica que, para Bateson, en realidad es simplemente un rodeo para continuar con sus propios intereses (más bien teóricos), esto es: el contexto de aprendizaje que posibilita la transgresión desde que postula la noción de "deuteroaprendizaje".

En segundo lugar, la interacción familiar en la esquizofrenia, que para Bateson era un medio, para otros era un fin en sí mismo. Don Jackson, psiquiatra y psicoanalista, se había incorporado al grupo alrededor de 1954, al tiempo que dictaba conferencias sobre "homeostasis familiar" donde algunos historiadores hallaron una "embrionaria teoría sistémica" (Bertrando y Toffanetti, 2004: 97). En 1956 Bateson, Jackson, Haley y Weakland publican "Toward a theory of schizophrenia", concebido luego como punto de origen para la concepción sistémica de la esquizofrenia y la familia, que destacaba el protagonismo de la teoría del doble vínculo. Tres años después de esta publicación, Jackson funda el MRI partiendo de la experiencia acumulada por el grupo de investigación dirigido por Bateson. Pocos años después se suman a la institución Watzlawick, Haley y Weakland.

A partir de la década de 1960 se produce en el hemisferio norte un fuerte interés por la terapia familiar en el marco de las nuevas problemáticas que la salud mental privilegiaba. En este contexto favorable, el MRI desarrolla algunas de las primeras terapias sistémicas caracterizadas por ser fundamentalmente familiares. Durante las décadas de 1960 y 1970 dicha institución será una suerte de meca para la terapia familiar y *Teoría de la comunicación humana* (1967), su libro de cabecera.

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos de la teoría sistémica por diferenciarse del psicoanálisis, inevitablemente se filtra en sus orígenes. Por una parte, cuando los intereses de Bateson tropiezan con la esquizofrenia, inevitable y automáticamente se incorpora en la larga serie de discusiones psiquiátricas respecto de esta patología, en las que el psicoanálisis ocupaba un lugar privilegiado. Por otra parte, se incorporan a su grupo de investigación psiquiatras con una importante formación psicoanalítica, como Jackson (que trabajó en Chestnut Lodge y basa su concepción de

homeostasis familiar en ideas psicoanalíticas) y Watzlawick (psiquiatra austríaco formado en psicoanálisis jungiano), autores de las principales publicaciones tanto del grupo de investigación de Bateson como del MRI.

Por último, cabe destacar que el cruce entre esquizofrenia y familia no se dio originariamente en el marco de las teorías sistémicas sino en el marco de las teorías psicoanalíticas que, durante las décadas de 1930 y 1940, dieron lugar a las investigaciones de Murray Bowen, Nathan Ackerman, Theodore Lidz y Lyman Wynne, entre algunos de sus principales representantes (Bertrando y Toffanetti, 2004; Macchioli, 2010a: 67).

Sintéticamente, puede sostenerse que el cruce entre cibernética y comunicación dio lugar a las investigaciones sobre la interacción familiar y la esquizofrenia accidentalmente, y que este cruce abrió un nuevo cauce con la teoría y la terapia sistémica, que se ocupó primero de la esquizofrenia para luego extenderse a una diversidad de padeceres. Esta vertiente fundó sus principios esencialmente en *Teoría de la comunicación humana*. Sin embargo, la terapia familiar, si así puede denominársela, se inició en un seno psicoanalítico no ortodoxo, para luego ampliarse, enriquecerse y difundirse a partir de los desarrollos del MRI. Por lo tanto, teoría sistémica, terapia sistémica y terapia familiar ni son sinónimos ni son contradictorias e incompatibles las teorías psicoanalíticas y sistémicas, a pesar de que por cuestiones relativas a la dinámica del campo disciplinar se presenten antagónicas para recortar un campo autónomo (Bourdieu, 1994 [1976]). De algún modo, el desenvolvimiento de estos saberes y prácticas del norte fueron interpretados en el sur como un conjunto cuasi homogéneo de conocimientos que se contraponían al psicoanálisis local en un tablero de ajedrez que obligaba en muchos casos a elegir entre negras y blancas.

En este tablero, Sluzki jugará un importante papel entre los desarrollos de la teoría sistémica y el campo disciplinar *psi* argentino. Tanto su temprana inserción en el Lanús, como su pronta incursión en el MRI para entrenarse interaccionalmente como terapeuta familiar marcaron las dos vías por las que transcurrirían los siguientes años entre Estados Unidos y Argentina para la configuración de la especialidad (Macchioli, 2012a).

A principios de la década de 1960 Sluzki trabajaba en el Lanús y se formaba en la APA, a la vez que investigaba y leía con Verón a Lévi-Strauss y Bateson. Estos encuentros produjeron sus frutos, entre los principales, el modelo de una familia entendida como sistema. Puede observarse que la operación de difusión de Sluzki de la teo-

ría interaccional fue amplia y prolífica. Desde las páginas de *Acta*, donde además de la transmisión de ciertos conceptos y actividades, figuran sus propios artículos con criterios sistémicos para distintos tópicos psiquiátricos, sus ponencias y discusiones en congresos, sus traducciones y compilaciones como *Interacción familiar*, y sus prólogos como el de *Teoría de la comunicación humana*, Sluzki no hizo más que incrementar la presencia de este enfoque hasta incluirlo en la agenda de las discusiones *psi* de la década de 1960. Esta cuestión lleva a delimitar dos términos que se entrecruzan, funden y rivalizan cuando se trata de terapia familiar: la estructura y el sistema. Ambos conceptos se propondrán como adversarios en el campo de la especialidad local, aunque en sus inicios prácticamente no se diferenciaba el uso de uno y otro.

La diferencia no se basó justamente en sus acepciones, bastante semejantes por cierto. Tanto Sluzki como Berenstein, representantes de lo que puede denominarse la familia-sistema y de la familia-estructura respectivamente, utilizan ambos términos multiplicidad de veces pero, a lo largo de los años, trazan distinciones cada vez más finas para delimitar a qué se refieren con "sistema" y "estructura". Finalmente, la noción que separará las aguas será la de "inconsciente".

En el hemisferio norte, la concepción de "sistema" para los autores de *Teoría de la comunicación humana* parte de los desarrollos de la cibernética en los que el concepto surgía de los planteos de la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy y de la definición de Arthur Hall y Robert Fagen, vinculado a la tradición de las disciplinas formales. Allí se sostiene que "un sistema es un conjunto de objetos, así como de relaciones entre los objetos y entre sus atributos, en el que los objetos son los componentes o partes del sistema, los atributos son las propiedades de los objetos y las relaciones mantienen unido al sistema" (Watzlawick *et al*., 1967: 117). De la estructura, ni rastros.

Del otro lado del Atlántico, la concepción de "estructura" de Lévi-Strauss en *Anthropologie Structurale* (1958) parte de la oposición entre "estructura social" (modelo teórico) y "relaciones sociales" (empíricas), distinción hecha desde la tradición de las disciplinas del lenguaje. El modelo, para denominarse "estructura", debe cumplir las siguientes condiciones: presentar el carácter de un sistema en el cual la modificación de un elemento modifica al resto; que las propiedades del modelo permitan predecir cómo reaccionará el modelo si uno de sus elementos se modifica, y, finalmente, el modelo debe poder dar cuenta de todos los hechos observados (Lévi-Strauss, 1968:

251-252). Así, en la definición misma de "estructura" se enlaza el término "sistema", aunque nada remite a la acepción que estaba gestándose en Norteamérica.

Mientras tanto, en la Sudamérica austral, un psicoanálisis de corte social se expandía rápidamente por la sociedad y por las disciplinas *psi*. Mientras que, a mediados de la década de 1960, Berenstein y Sluzki se encontraban en la APA, Verón se posicionaba como la clave de acceso a la estructura y al sistema para hacer confluir la tradición norteamericana y la francesa en la Argentina.

Hasta aquí puede localizarse un tronco común, a partir de Saussure y Lévi-Strauss, del que parten las primeras lecturas locales estructuralistas. Así y todo, Sluzki en aquellos años nunca cita a Lévi-Strauss, sino que refiere a los artículos de Verón que tratan sobre la obra del antropólogo francés. Esto da lugar a un malentendido. Mientras que Verón se ocupa de la "estructura", a la que se supedita la noción de "sistema" del autor del *Curso de lingüística general*, Sluzki se acerca a los autores del MRI y trabaja hasta la publicación de *Comunicación y neurosis* con ambas acepciones en simultáneo: el sistema interaccional de la Escuela de Palo Alto en la que el "inconsciente pierde su importancia" (Watzlawick *et al*., 1967: 45), y el sistema estructural de Lévi-Strauss en el que el inconsciente deviene piedra angular de toda la teoría. Estas acepciones terminarán de diferenciarse después de 1970, cuando Sluzki se instala en Palo Alto y Verón en París. La cuestión del inconsciente, en particular, se retomará en el próximo apartado.

En la postulación de las "estructuras de conducta" como "modelo conceptual para el estudio sociológico de las psiconeurosis" se puede observar un híbrido particular que no durará más de diez años. En este concepto convive el psicoanálisis de corte social inaugurado por Pichon-Rivière, la estructura a la francesa y el sistema a la americana. Entretanto, desde 1965 se observa un giro en el vocabulario del psiquiatra lanusino. En sus artículos predomina el término "sistema" aplicado a "la díada como sistema interpersonal", "sistemas homeostáticos", "sistema diádico"; mientras que la "estructura" prácticamente no figurará más que para supeditarse a la idea de "sistema" e "interacción". Luego, desde 1968 refiere frecuentemente al "enfoque interaccional", y desde 1969 a la "interacción familiar". Del inconsciente, no se habla.

De este modo, las investigaciones de Sluzki sobre comunicación y neurosis, y las de interacción y esquizofrenia irán por caminos paralelos durante los siguientes cinco años. Esta situación hace que Sluzki se mantenga a caballo entre las ideas sistémicas y psi-

coanalíticas. Por una parte, la articulación entre comunicación y neurosis mantendrá la idea de inconsciente que se extenderá hasta la concepción de estructuras de conducta aprendidas en el seno del grupo familiar, como se abordará en los próximos apartados. Por otra parte, el resto de sus investigaciones entre el Lanús y el MRI dejarán el inconsciente fuera del juego: no lo niegan, pero no se ocupan de él. Se interesarán, en cambio, en la interacción, en los procesos comunicacionales que se basan en la puntuación, en los niveles de contenido y de relación, y en la comunicación verbal y analógica. Sluzki sostiene que "el esquema interaccional permite entender de otra manera procesos descriptos hasta ahora en términos de una causalidad lineal" (Sluzki y Bleichmar, 1968: 328). La fórmula "sistema familiar", a pesar de no ser muy utilizada por Sluzki, es la que prevalecerá en aquellos terapeutas que adhieran a la teoría sistémica para tratar familias, en la que el inconsciente irá quedando relegada a los márgenes.

Este escenario permite establecer que la introducción del estructuralismo en la Argentina, entre sus diversos efectos, posibilitó un entramado de ideas a la que se sumaría la teoría sistémica, a partir de la confluencia que Bateson había trazado una década antes entre cibernética y psiquiatría. En el comienzo, prevalecerá la idea de "estructura" aunque, a partir de la implantación de la teoría sistémica a través de Sluzki, se sumará la idea de "sistema" con su propio cuerpo teórico-clínico. Entretanto, mientras que el "sistema" se alejará cada vez más del inconsciente, la "estructura" se ensamblará a él y promoverá distintos modelos teóricos a partir de las lecturas de Lacan o Lévi-Strauss.[29] El nuevo vocabulario empleado que combina conducta, neurosis, comunicación e inconsciente, parece sólo asequible en dicho contexto de producción intelectual en el que se ponía en diálogo un psicoanálisis extendido a lo social con el despliegue en su máxima expresión de las ciencias sociales en el ámbito local.

Pocos años después, cambiarán las condiciones del campo intelectual y disciplinar. Muchas de estas incipientes mixturas sucumbirán en climas sociales y políticos que, aunque áridos y problemáticos en varios aspectos, producirán territorios con otras fronteras.

29. Para profundizar esta cuestión, puede consultarse el artículo de Dosse, "El inconsciente: un universo simbólico" (2004: 135).

Un psicoanálisis a medida de la familia

El desafío de Verón y Sluzki, además de establecer cierto cruce entre la estructura y el sistema, debía articular la neurosis y la comunicación. Respecto de esta última, se ha planteado su vínculo con la teoría de los sistemas y la teoría de la comunicación humana conformada en el hemisferio norte, mientras que el psicoanálisis al que adherirán los autores se consolidaba en el hemisferio sur. En esta dirección, se presentará a continuación desde qué criterios entendían Verón y Sluzki la neurosis para articular la comunicación, la neurosis y la posición de la familia en la etiología de esa psicopatología en el próximo apartado.

En principio, parten de los mensajes de los pacientes neuróticos para estructurar una suerte de "prototeoría" de la neurosis desde el punto de vista comunicacional (Verón y Sluzki, 1970: 229). Para esta "teoría comunicacional de la neurosis", plantearán primero qué entienden por las tres configuraciones neuróticas seleccionadas: la estructura de conducta histérica, la estructura de conducta fóbica y la estructura de conducta obsesiva.[30] Vale aclarar que aquí sólo se mencionarán algunos de los aspectos que luego se relacionarán con la dinámica familiar sin profundizar en las cuestiones individuales y las comunicacionales en las distintas estructuras.

Los autores destacarán en la estructura de conducta histérica el complejo de Edipo como estructura clave, resuelto mediante la represión de lo genital y la apreciación de conductas sustitutivas. Allí podrá ubicarse una suerte de collage de estilos que combina vínculos adultos e infantiles en su comportamiento. En determinadas circunstancias puede activarse el conflicto inconsciente, haciendo emerger impulsos sexuales que son vividos como prohibidos o incestuosos. El consiguiente miedo y la culpa que dan lugar al segundo frente de mecanismos de defensa que se centran en la conversión permiten reemplazar el conflicto por el síntoma somático y que lo inconsciente no devenga consciente. Para extender esta teoría, Verón

30. Para desarrollar el concepto de "estructuras de conductas" se basan, entre otros autores, en el Bleger de *Psicología de la conducta* (1963) (Verón y Sluzki, 1970: 43). Dicha referencia permite dar cuenta en primer lugar de que Sluzki estaba al tanto de los desarrollos psicoanalíticos de corte social inaugurados por Pichon-Rivière. Además, permite entrever la heterogeneidad teórica en el zócalo mismo de la investigación iniciada con Verón, en la que convivían la sociología, la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología, la fenomenología, el estructuralismo y la teoría de los sistemas, entre otras.

y Sluzki continúan con los desarrollos de Freud, quien entiende que los síntomas conversivos de la histeria son a la fantasía inconsciente como el contenido manifiesto del sueño al contenido latente, o al decir de David Liberman, que el cuerpo de los histéricos equivale a una "pantalla onírica" (Liberman, 1962). En este sentido, la disociación de la histeria genera en sus vínculos significativos una conducta inocente y seductora, aunque no tenga consciencia de dicha conducta seductora. En la entrevista seleccionada por los autores para ejemplificar esta estructura de conducta, predomina la relación de la paciente con el padre y la madre.

En segundo lugar, la estructura de conducta fóbica se refiere a todo miedo asociado a situaciones u objetos que no constituyen en sí mismas una fuente de peligro, e incluso el sujeto sabe que no lo constituyen. Liberman lo expresó como "la personalidad atemorizada e huidiza". La fobia es la neurosis infantil por excelencia y en la adultez se repetirá en modo recreado. Aquí Verón y Sluzki retoman el "caso Juanito" de Freud y la raigambre edípica del conflicto: la agresión al padre fue reprimida y disociada, proyectándola a un objeto exterior, el caballo, además de una regresión de los conflictos edípico-genitales a las ansiedades castratorias oral-sádicas (más primitivas en cuanto al punto de vista del desarrollo libidinal). En este sentido, el estado de alerta de los pacientes fóbicos se traduce en una búsqueda permanente de "cualidades protectoras o fobígenas de los objetos" desde los desarrollos de Fairbairn (Verón y Sluzki, 1970: 73). Esto lleva a la evitación de toda situación que pueda provocar angustia, en la que "controlan" al interlocutor para que éste no incursione en temas que puedan desencadenar la ansiedad del sujeto. En la entrevista seleccionada por los autores para ejemplificar esta estructura de conducta predomina la sensación del sujeto de que "el mundo es muy grande para mí o que yo soy muy chico para el mundo" (75).

Por último, la estructura de conducta obsesiva se caracteriza por tres variantes de un mismo estilo sintomático: ideas compulsivas, pensamientos obsesivos y conductas rituales. Éstos se le imponen al sujeto, quien los vive como sinsentido, contra los que lucha o se angustia. Estos síntomas se incrustarán en una personalidad particular que fue denominada "sádico-anal" por Sigmund Freud y Karl Abraham, o "personalidad lógica" por Liberman. El análisis psicodinámico pone de manifiesto un complicado sistema de prohibiciones contra pulsiones básicamente sádico-anales cargadas de odio, en las que predomina la formación reactiva como mecanismo defensivo, dando por resultado la ambivalencia a través de los afectos contra-

puestos que coexisten en el sujeto. En la entrevista que seleccionan los autores para ejemplificar esta estructura de conducta domina la relación de la paciente con su hermano.

Es notorio el modo en que Verón y Sluzki presentan las tres configuraciones neuróticas. Se basan claramente en la teoría freudiana y la complementan en todos los casos con los desarrollos de Liberman de *La comunicación en terapéutica psicoanalítica* (1962) presentados anteriormente. No parece casual que los caminos de Liberman y Sluzki se hayan encontrado en algún recóndito momento de sus trayectorias. De hecho, justamente esa coyuntura se da en los primeros años de la década de 1960 en la carrera de Psicología de la UBA, cuando Sluzki fue jefe de Trabajos Prácticos de la materia de Psicopatología, dirigida por Liberman (contexto en el que, por otra parte, el psiquiatra lanusino conoció a algunas figuras que serían relevantes para la terapia familiar como María Rosa Glasserman y Cloë Madanes en la década siguiente). Más tarde, Sluzki iniciaría su formación y entrenamiento psicoanalítico en la APA hasta 1967, mientras trabajaba en el Lanús y era miembro del equipo de investigación dirigido por Verón, como se mencionó con anterioridad.

Volviendo a la operación de Verón y Sluzki, poner en diálogo a Freud y Liberman abre la vía de acceso al nexo entre comunicación y neurosis hacia el interior del psicoanálisis. Incluso, Liberman titulará uno de sus libros poco más tarde como *Comunicación y psicoanálisis* (1976). Liberman, de hecho, fue de los pocos analistas que trabajaron esta intersección. Y, a pesar de que sus intereses se concentraban en el vínculo transferencial, su modelo teórico abrió diversas producciones. Ya en el prólogo al libro de 1962, Pichon-Rivière da dos claves de acceso para Sluzki y Verón: primero, que el interés de Liberman se centra en gran medida en el interjuego entre individuo y sociedad; segundo, sitúa a Liberman como un sociólogo que instrumenta la historia para establecer la secuencia de las interpretaciones que realiza a los pacientes en términos de una comunicación perturbadora y aprendida deficientemente (Liberman, 1962: xii-xiii).

En *Comunicación y neurosis* Sluzki y Verón se basan en ideas psicoanalíticas, aunque no en Otto Fenichel como lo hace Liberman, sino en Fairbarn. La bifurcación que se observa en cada uno de estos cuerpos de ideas responde a los diversos intereses de Liberman, por una parte, y de Sluzki y Verón, por otra.[31] De hecho, estos últimos

31. Como se mencionó anteriormente, Liberman combina a Ruesch con Fenichel, a diferencia de Verón y Sluzki que trazarán la intersección entre Bateson y Fairbarn.

retoman fundamentalmente los aportes psicoanalíticos de Fairbairn sobre las neurosis y las etapas de dependencia infantil, transición y dependencia madura en los que se extiende la mirada hacia la familia.[32] Sin entrar detalladamente en esta teoría, la etapa intermedia es aquella en la que el sujeto debe aprender a romper la identificación con la dependencia infantil, etapa en la que pueden establecerse los trastornos neuróticos. Así, si en la etapa de dependencia predomina el "incorporar" los objetos, en la etapa de madurez predomina la actitud de "dar". De tal modo que la etapa de transición plantea el esfuerzo del niño por "desprenderse" de los objetos incorporados y es entonces cuando el sujeto puede hacer uso de "técnicas" histéricas, fóbicas u obsesivas. La cristalización, a partir del predominio de alguna de ellas como sistema adaptativo del individuo, denuncia la presencia de un conflicto transicional no resuelto, conflicto que estará relacionado de alguna manera con la situación de socialización, más precisamente con la situación familiar que el sujeto atraviesa. Esto será ampliado a partir de los "modelos de aprendizaje" que pueden llevar a la cristalización neurótica. Según los autores, de acuerdo con Fairbarn, los conflictos básicos que se le presentan al sujeto en la etapa oral primaria (esquizoide) y la oral secundaria (depresiva) estarán vinculados a la relación del niño con su madre y, fundamentalmente con el modelo de socialización que ésta aplica. Así, todo modelo de aprendizaje consistirá en un sistema de reglas de distribución de premios y castigos entre el agente socializador y el sujeto socializado. De tal modo, el proceso de socialización tendrá por objetivo, teóricamente, estimular la independencia del objeto y neutralizar la unión con él.

Luego de esta sucinta puntualización de lo que entienden por neurosis Sluzki y Verón, cabe señalar algunas particularidades. Sluzki prácticamente en ninguna de sus investigaciones aborda cuestiones como el inconsciente, la fantasía inconsciente, el complejo de Edipo o las pulsiones. Lógicamente tratar la entidad de "neurosis" obliga incorporar la teoría psicoanalítica, aunque los autores se toman la libertad de establecer cruces novedosos incluso con los autores psicoanalíticos, que tanto el Lanús como *Acta* impulsaban en un clima de época propicio para tales combinaciones.

32. Vale señalar que Klein incorpora a su posición paranoide los aportes de Fairbarn sobre los aspectos esquizoides que predominan en la fase oral primaria, que da lugar a la denominación de "fase esquizo-paranoide". Los desarrollos citados por Sluzki remiten a W. Fairbarn, *Estudio psicoanalítico de la personalidad*, Buenos Aires, Hormé, 1962.

En esta dirección, se pondrá el acento en dos conceptos vertebrales para el psicoanálisis: el complejo de Edipo y el inconsciente. Respecto del primero, puede observarse que los principales profesionales que realizaron un aporte original psicoanalítico para el abordaje familiar debieron reformular varios conceptos, fundamentalmente el complejo de Edipo, noción que inscribe la organización familiar en el aparato psíquico. Es así como Pichon-Rivière, entre los primeros profesionales que encararon esta tarea, transforma el complejo en función de distintas vertientes teóricas para que éste pueda extenderse al grupo familiar externo y no ya sólo a su representación interna (Macchioli, 2007, 2010a, 2010c, 2012b). Por su parte, Sluzki prácticamente no menciona el complejo de Edipo en sus investigaciones y, si lo señala en *Comunicación y neurosis*, aparece ligado a las concepciones psicoanalíticas freudianas que fundan en la conflictiva edípica los tres tipos de neurosis. Incluso, en esta obra se podrá observar el desplazamiento de la conflictiva edípica de Freud al conflicto de dependencia-independencia de Fairbairn, núcleo en el que sitúan la etiología de las neurosis desde el punto de vista comunicacional. Este desplazamiento permite extender la enfermedad mental del sujeto a la familia en clave comunicacional al poner en diálogo al sujeto con otros sujetos.[33] Este movimiento no es menor en tanto corre el foco de la sexualidad a la autonomía del sujeto. Éste puede ser uno de los motivos que explique por qué Liberman cruza la teoría de la comunicación de Ruesch (psiquiatra) con el psicoanálisis de Fenichel que tiene por eje las fases libidinales, a diferencia del cruce de Verón y Sluzki entre Bateson (antropólogo) con Fairbarn, quien estructura las neurosis desde el proceso de socialización.

Respecto del inconsciente, la situación se vuelve mucho más compleja por diversas razones. La primera, es que ninguno de los autores que teorizaron sobre la intervención terapéutica familiar afrontó el desafío que implicaba reformular la noción de inconsciente aunque debían trabajar con ella permanentemente. La segunda, asociada a la primera, es que intervenir familiarmente obligaba a concebir a la familia por fuera del ámbito psíquico, pero sin perder dicha conexión. Y aunque se trazaron diversos modelos que vinculaban la representación psíquica de la familia con la dinámica grupal familiar, ninguno de ellos modificó el inconsciente en la teoría, si

33. A diferencia de Pichon-Rivière, para quien la clave de extensión de la conflictiva edípica del sujeto (grupo interno) al grupo familiar será el vínculo (Macchioli, 2007, 2010a).

bien necesariamente se alteró en la práctica. A partir de un abordaje histórico, pueden ensayarse algunas hipótesis al respecto.[34]

El primer autor que incursionó en los tratamientos familiares en el país y que abrió el surco para los siguientes profesionales fue Pichon-Rivière. El cauce que inauguró cobró forma de delta durante la década de 1970, cuestión que dificulta trazar puntos de origen, ya que ese punto es, a la vez, resultado de la confluencia de otros tantos afluentes. No obstante, pueden ensayarse ciertas conjeturas a partir de tal huella. La obra de Pichon-Rivière fue más que compleja y su abordaje del grupo familiar implica tirar de una red enmarañada de ideas, autores, prácticas, instituciones, teorías y disciplinas. Asimismo, aunque el inconsciente en Pichon-Rivière no está mayormente explicitado en su obra, hay que saber buscarlo en los juegos de tensiones y ambigüedades de sus ideas (Macchioli, en prensa).

Sin entrar en un fino análisis, la familia en Pichon-Rivière plantea un anverso y un reverso: el grupo interno y el grupo social. Particularmente el grupo interno, entendido como las relaciones familiares internalizadas en el psiquismo (concepto que puede pensarse en el encuentro entre las fantasías inconscientes de Klein y el otro generalizado de Mead), permite extender las concepciones freudianas a una clave vincular intrapsíquica (Vezzetti, 2002). Aunque casi no tratado por la enorme cantidad de profesionales que se autodenominaron sus discípulos, el grupo interno devino un concepto más que fecundo.

Por una parte, Pichon-Rivière lo ubicó en su concepción de "series complementarias", constitutivas del aparato psíquico y fue uno de los principios de la teoría de la enfermedad única en la que trata a la familia en dos dimensiones: el vínculo intrauterino y el impacto del grupo familiar en el sujeto. Por otra parte, el complejo de Edipo, entendido como situación triangular, incorpora el interjuego de vínculos familiares a nivel intrapsíquico. Es así como el grupo interno, que se constituye en un primer momento por las relaciones familiares externas que se internalizan, pasa, en un segundo momento, a proyectarse a los vínculos externos en un interjuego dialéctico entre el afuera y el adentro.

Entre estos múltiples cruces en la obra de Pichon-Rivière, puede observarse un original maridaje entre los objetos internos a la

34. No se precisarán aquí las distinciones conceptuales entre el inconsciente de Freud, Klein, Levi-Strauss o Fairbarn, entre tantos otros. A los fines del trabajo, sólo se analizarán algunas ideas alrededor del inconsciente en Pichon-Rivière y sus efectos en los posteriores autores que abrevaron en este cauce.

inglesa (Melanie Klein) con la dinámica de grupos a la americana (George Mead y Kurt Lewin) que daría sus propios frutos: una suerte de "inconsciente vincular". En este sentido, los intereses de Klein alrededor de la psicosis y el psicoanálisis infantil, a pesar de incluir las relaciones materno-filiales, se centraba en el mundo interno e individual. Pichon-Rivière, en cambio, a pesar de incluir tales ideas en su esquema conceptual, estaba interesado en el germen vincular que conecta al individuo y a la sociedad, a través del grupo familiar, en el que la locura pasa a ser simplemente una de las expresiones enfermas de dicho vínculo. De hecho, desde Pichon-Rivière el complejo de Edipo formará parte de una trama vincular (a modo de situación triangular) entre un adentro y un afuera del sujeto. Este inconsciente vincular, aunque desapercibido hasta para el propio Pichon-Rivière, fue una de las ideas más prolíficas de su obra por habilitar la prolongación del mundo interno psicoanalítico al tratamiento del grupo familiar. Dicha concepción, utilizada por los profesionales que continuaron este surco, operó en forma latente a modo de un inconsciente de tipo relacional que se nutriría más tarde de la vertiente estructuralista de Lévi-Strauss (Macchioli, 2010b, 2010c).

Volviendo a *Comunicación y neurosis*, Verón es el enlace entre el antropólogo francés y la comunicación, mientras que Sluzki es el nexo entre Pichon-Rivière y la neurosis. Y aunque este último vínculo ha sido poco trabajado, probablemente para reforzar el lazo del psiquiatra lanusino con Norteamérica mientras se prescindía de su relación con la Argentina, algunos de ellos pueden reconstruirse. En los primeros escritos de Sluzki pueden esbozarse algunas bases que progresivamente serán dejadas de lado en los subsiguientes artículos. De hecho, la trama intelectual en la que Sluzki produce su obra está inserta ineludiblemente en el psicoanálisis y los aportes pichoneanos. Su formación en la APA, así como su encuentro con Liberman y la incorporación de Fairbairn en sus investigaciones alrededor de *Comunicación y neurosis*, permite trazar una suerte de filiación que, aunque no prevalecerá en la década de 1980, forma parte de los cimientos de su esquema conceptual.

Sluzki remite en sus primeros artículos al autor de *Teoría del vínculo* para referirse a distintas ideas de su matriz conceptual. En 1963, en paralelo a su primer artículo con Verón, escribe otro artículo referido al grupo familiar del paciente internado, en el que puede localizarse una fuerte impronta pichoneana combinada con la tipología familiar de Don Jackson (en aquel entonces director del MRI). Es así como la incapacidad del neurótico para elegir en-

tre un repertorio de respuestas acotado produce "estereotipia" y el pronóstico del paciente se basará en la receptividad o no del grupo familiar. Casualmente los tratamientos en el Lanús se denominarán "psicoterapia del grupo familiar", como los nombraba Pichon-Rivière. Asimismo, Sluzki propone aquí una formula curiosa: una "gestalt dinámica de complementación inconsciente", referida a la relación de una persona neurótica que elige como pareja a alguien con quien comparte una interacción complementaria que evidencia la estereotipia y la ansiedad de sus miembros. Mientras que las ideas de Gestalt, dinámica y complementación parecen enraizarse en la tradición norteamericana de la psicología social y la cibernética, el inconsciente remite a ideas europeas ya arraigadas e implantadas en la Argentina años atrás. Así y todo, la fórmula de Sluzki parece habilitar una lectura que incluye un inconsciente vincular (con reminiscencias kleinianas) y una Gestalt y dinámica grupal, que remiten al particular ensamble de Pichon-Rivière en su teoría del vínculo. Por ello, puede ubicarse tempranamente en los primeros escritos de Sluzki una novedosa articulación entre la teoría vincular pichoneana, el interaccionismo de Jackson y el deuteroarendizaje batesoniano en la que la familia cobra un rol protagónico. Así, Sluzki conjugaba hacia 1963 una concepción psiquiátrica con aportes que comenzarían a alejarse entre sí: por un lado, la teoría del vínculo de un psiquiatra que estaba tomando distancia de la APA para abrir un nuevo cauce destinado a la psicología social; por otro, una ortodoxia psicoanalítica a la inglesa nucleada en la filial argentina de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA), lugar en el que Sluzki se formaría a mediados de la década de 1960, y, por último, los nuevos aportes del MRI sobre interaccionismo que el investigador del Lanús descubría a través de Verón.

Sin embargo, además del cruce de categorías clásicas psicoanalíticas como el complejo de Edipo o el inconsciente de cara a la comunicación, pueden trazarse algunas especificaciones con respecto a la relación de la comunicación de cara al psicoanálisis.

El dilema "dependencia-independencia" de Fairbairn como un problema "universal" que se presenta en toda situación de socialización permite introducir de qué modo se transmiten metacomunicativamente las reglas de la situación de aprendizaje, que lleva a la noción de "deuteroaprendizaje" de Bateson, así como destaca el modo en que los agentes socializadores definen la situación de aprendizaje. Por ello, "las contradicciones o incongruencia no pueden tener otro origen que los propios conflictos neuróticos de los agentes socializadores, tal como se expresan en su relación con el niño" (Verón y

Sluzki, 1970: 241). Por lo tanto, el dilema de dependencia-independencia, a la par de los conflictos neuróticos de los padres, producirá en cada caso un tipo específico de organización interaccional en el aprendizaje y, en consecuencia, un determinado "modelo socializador", que posee pautas regulares de interacción que a largo plazo pueden devenir trastornos neuróticos específicos.

En el marco del deuteroaprendizaje, el doble vínculo, que servía de hipótesis explicativa a la etiología de la esquizofrenia, puede generalizarse como "situación patogénica universal" a toda situación socializadora que posea incongruencias y contradicciones (Verón y Sluzki, 1970: 242). No obstante, hay dos interrogantes que dirigen a los autores, continuando a otros que trataron de responder estas mismas cuestiones: por qué en un medio socializador con contradicciones reiteradas ciertos sujetos desarrollan una conducta psicótica y otros una conducta neurótica y, en este último caso, por qué se produce una neurosis determinada (histeria, fobia, obsesión). A modo provisorio, parten de los análisis de Fairbairn sobre su teoría del desarrollo de las relaciones de objeto, basado en la dependencia del objeto,[35] desde los que se sostiene que, si las contradicciones surgen muy precozmente en los procesos socializadores, darán lugar a la esquizofrenia, mientras que si ocurren más tardíamente, darán lugar a la neurosis. Se parte del supuesto de que, si el medio socializador no incluyó contradicciones tempranas, esto proveerá de una base más sólida para los rasgos nucleares de la personalidad. De ahí, Sluzki y Verón hipotetizan, inspirados en la teoría de la comunicación, que los medios socializadores que generan neurosis no sólo definen situaciones incongruentes reiteradas, sino que favorecen o refuerzan a la vez ciertas "salidas" a esas situaciones, cierto escape ante la paradoja (a diferencia de la psicosis, donde no se generan vías de escape). De este modo el neurótico privilegiará el estilo de respuesta que el mismo medio que las plantea favorece. A la vez, los factores genéticos incrementarán o disminuirán la "virulencia" de las situaciones de socialización, por lo que no se descarta aquí el peso indudable de los factores genéticos en la etiología de la esqui-

35. Fairbairn, de hecho para delinear su teoría reformula conceptos freudianos a la luz de las ideas de Klein y de Abraham. De la primera retomó fundamentalmente las relaciones de objeto y del segundo, sus fases libidinales. Para Fairbarn la etapa de dependencia infantil corresponde a la fase oral primaria y secundaria de Abraham, la etapa de dependencia madura a la segunda fase genital, mientras que las dos fases anales y la primera fase genital corresponden al período de transición (Fairbairn, 1962: 47).

zofrenia, aunque pasan a ser un factor lateral en la comprensión de la patología.

Para los autores, ni el modelo interaccional es incompatible con los elementos esenciales de la teoría psicoanalítica, ni desconocen que los conflictos que generan las situaciones de incongruencia puedan conceptualizarse como fantasías inconscientes, mecanismos de defensa o desarrollo libidinal, aunque privilegiarán la interacción y el aprendizaje más que los componentes afectivos.

La trama intelectual y profesional que representa *Comunicación y neurosis* parte de la relación entre individuo y sociedad, así como de la distinción entre salud mental y enfermedad mental, para hallar en la familia su piedra angular.

La familia entre la neurosis y la comunicación

Hasta aquí se han expuesto las particulares características de la implantación de la teoría sistémica en la Argentina, en cuyo origen la figura de Verón imprimió un sello estructuralista. Sin embargo, la difusión que promovió Sluzki en el campo de las disciplinas *psi*, fundamentalmente desde 1965 luego de su incursión al MRI, fue perdiendo el barniz de su entrada desde el estructuralismo francés para expandir la matriz puramente norteamericana, en la que la "estructura" debió ceder paso al "sistema".

No obstante, ambas ideas coexistieron en las producciones de Sluzki sobre psicoterapia familiar por lo menos hasta principios de la década de 1970. Por una vía continuó la investigación con el equipo de Verón que, iniciada en 1963, concluyó en la publicación de *Comunicación y neurosis* (1970). En este escrito prevalece el concepto de "estructuras de conducta", anteriormente mencionado, y se combina con la concepción psicoanalítica de Fairbairn (que posee varias afinidades con la teoría de Klein). De este modo, así como la noción de estructura estará explícita, la de inconsciente será implícita a lo largo de la investigación. Y allí la familia ocupará una posición estratégica.

Para incursionar en *Comunicación y neurosis*, hay que tener presente el interés de Sluzki por una integración entre la perspectiva sistémica y la psicoanalítica que, sin embargo, no será la que prevalecerá en el conjunto de profesionales que adhieran a la familia entendida como sistema.

Sluzki, el único psiquiatra que provenía del Lanús, se sumó al equipo de investigación dirigido por Eliseo Verón. El resto de los inte-

grantes pertenecían al Departamento de Sociología, entre ellos, Ana Lía Kornblit, Francis Korn y Ricardo Malfé. Entre 1964 y 1966 el equipo de Verón contó con una beca de Conicet para el proyecto "Estructuras de comunicación y sistemas de comunicación social". El trabajo de campo se centró fundamentalmente en el Policlínico de Lanús, aunque algunas tareas se realizaron en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Alvear y el Servicio de Psicopatología y Neurología del Policlínico de Avellaneda. Uno de sus primeros objetivos fue plantear, sobre la base de investigaciones norteamericanas sobre esquizofrenia, que los trastornos mentales no están distribuidos al azar entre los distintos niveles de estratificación social, hallándose mayor prevalencia de psicosis en los estratos bajos y mayor frecuencia de neurosis en los estratos "más elevados", lo que permitía afirmar que "la prevalencia diagnosticada de los desórdenes psiquiátricos está significativamente relacionada con la posición del individuo en la estructura de clases" (Verón *et al.*, 1963: 298). A pesar de que esta hipótesis no pudo ser avalada por las investigaciones norteamericanas efectuadas hasta 1959, dichos interrogantes dirigieron la mirada a la familia como posible agente etiológico. Esto llevó a plantear que la enfermedad mental, además de ser producto de la interacción familiar, cumplía la función, dentro del grupo, de canalizar tensiones y conflictos. De hecho, así como la familia puede dificultar el proceso de curación, puede plantearse la vía contraria: que la modificación de las pautas de conducta de un solo miembro a través de la psicoterapia afecte al equilibrio familiar y modifique el papel del "enfermo" en la interacción grupal. Así y todo, no dejan de lado que la explicación por la vía biológica complemente y no contradiga el modelo sociocultural para explicar la etiología de los desórdenes mentales. De este modo, sería necesario abarcar tres niveles en la investigación: el individual (a partir del diagnóstico), el familiar (a través del estudio de la estructura del grupo), y el de la estratificación social y las estructuras culturales (que incluyen los valores y la ideología de clase). El marco teórico para trabajar con estos niveles será la teoría de la comunicación, en la que Verón venía trabajando desde poco tiempo antes.[36] La hipótesis con la que trabajarán será que "resulta estratégico considerar que los trastornos mentales se hallan etiológicamente vinculados a perturbaciones en los sistemas sociales de comunicación" (Verón *et al.*, 1963: 301).

36. Aquí se refiere específicamente a la teoría de la comunicación como la convergencia de la lingüística de Saussure y la cibernética (Verón, 1963: 289). El artículo de 1963 presenta en germen muchas de las ideas que se continuarán en *Comunicación y neurosis* (1970).

Y aquí, sin más, toman los estudios del equipo dirigido por Bateson sobre la familia y el doble vínculo.

A partir de estas premisas, el grupo de investigación planteará ya en 1963 un modelo conceptual para estudiar la conducta fóbica, obsesivo-compulsiva e histérica, por ser éstas estructuras claramente delimitables y por integrar un sistema de relaciones. Las hipótesis de este modelo conceptual sintéticamente son las siguientes:

1) Las estructuras de conducta son "determinadas formas de organización del comportamiento aprendido del individuo, es decir, a ciertas configuraciones típicas de respuestas ante situaciones, personas o cosas". Este "sistema" de conductas refiere a las respuestas observables en un individuo y como "estructura", a las configuraciones de respuestas recurrentes con las que un individuo enfrenta ciertas situaciones.
2) Las denominaciones tradicionales de los síndromes fóbico, obsesivo-compulsivo e histérico suponen estructuras de conducta recurrentes. El neurótico se caracteriza por la incapacidad de elección entre un repertorio de respuestas posibles (definido por factores biológicos, psicológicos y culturales) y la estereotipia de respuesta dada.
3) Las estructuras de conducta neuróticas son modalidades específicas de funcionamiento de los "procesos de recepción, elaboración y transmisión de la información del sistema de comunicación en que se encuentra el individuo". El modelo del sistema de comunicación que emplean incluye los elementos (fuente, destino, canal, código y referente), funciones (denotativa, emotiva, conativa, pática y metalingüistica) y operaciones (emisión, codificación y recepción analógica o digital).
4) Lo que se entiende por "estructura de conducta predominante" en un individuo adulto es el resultado de la recurrencia de ciertas modalidades de comunicación durante el proceso de socialización, entendido como modelo de aprendizaje. No implica los contenidos de lo aprendido, sino las características formales en las que se transmitieron dichos contenidos.
5) La recurrencia de estructuras de conducta en un individuo es el resultado de un proceso metacomunicativo de aprendizaje, o sea de "deuteroaprendizaje".[37]

37. Como se indicó anteriormente, refiere al aprendizaje que se adquiere de la situación en que se aprende. Implica procesos de comunicación del contenido y de metacomunicación acerca de las características estructurales de la situación.

6) Por ello, "la existencia de modelos recurrentes de aprendizaje en un grupo familiar es función de las formas de organización de la familia como sistema de comunicación". Esta afirmación puede ubicarse como punto de partida para elaborar una tipología de sistemas de comunicación familiar, asociados a la emergencia de ciertas estructuras de conducta de un individuo que se tome como referencia. Entendido así, el aprendizaje sería tan sólo un fragmento del sistema familiar total de comunicación. De aquí se desprende que un modelo de procesos informacionales dentro del grupo familiar debería considerar: a) los procesos de transmisión de mensajes y de la naturaleza de la relación (congruente e incongruente) entre mensajes y metamensajes; b) las funciones de comunicación en cada miembro del grupo familiar (denotativa, emotiva, pática, conativa), en la recepción y la emisión; c) el sistema de codificación predominante (analógico o digital) en cada miembro de la familia, y d) la determinación de las situaciones de comunicación recurrentes en la familia, así como la ubicación del individuo en dichas situaciones. Esto supone dos hipótesis: que hay correspondencia entre la comunicación predominante del grupo familiar y las estructuras de conducta de los hijos, y que esta correspondencia surge de los modelos de aprendizaje establecidos por los agentes socializadores para cada hijo.
7) La existencia de determinados tipos de comunicación en el grupo familiar está en función del contexto sociocultural en el que éste se encuentra, particularmente su clase social. Si las hipótesis hasta aquí expuestas son correctas, se podría hallar en este nivel una distribución diferencial de las estructuras de conducta según la estratificación social, que se explicaría por: a) una distribución diferencial de los tipos de comunicación familiar según la clase social; b) una correlación entre la ideología (entendida por las ideas y los valores de clase) y la ideología familiar, a partir de dos niveles: las ideas y los valores de los agentes socializadores que organizan el aprendizaje de los hijos; y el modo en que la familia organiza la comunicación y la interacción grupal. En este último punto, lo que más interesa investigar son las reglas de transformación que explican el pasaje de una estructura de significados (tanto de la ideología de clase como de la ideología familiar) al plano de la comunicación y la interacción familiares.

En síntesis, del planteo de 1963 pueden desprenderse algunas cuestiones. En principio, los interrogantes de los investigadores partieron de las psicosis, particularmente de la esquizofrenia, donde hallaron varias investigaciones norteamericanas que no terminaban de producir modelos compatibles entre los desordenes psiquiátricos individuales, la estructura de clases y la etiología biológica que podía observarse en estos desórdenes. Así, a partir de la posición del enfermo en la "interacción familiar", se proponen abarcar tres niveles de investigación (individual, familiar y estratificación social), basados en los desarrollos sobre teoría de la comunicación, más específicamente en los aportes de Bateson y su grupo sobre el doble vínculo como situación comunicacional particular en la esquizofrenia. Esto lleva al equipo de investigación a plantear la hipótesis de que los trastornos mentales se encuentran etiológicamente vinculados a perturbaciones en la comunicación, pero para abordar sistemáticamente esta afirmación trabajarán con las conductas neuróticas (fóbica, obsesivo-compulsiva e histérica), por ser "estructuras claramente delimitables e integrar un sistema de relaciones". De este modo, la psicosis aquí quedó postergada a pesar de haber sido la puerta de entrada al problema.

Esas serán las primeras investigaciones en el país que se detendrán en la relación entre conducta neurótica, grupo familiar y sociedad, además de ser las primeras en asociar los desarrollos del MRI con el tratamiento familiar en la Argentina. Términos como "sistema" o "comunicación digital y analógica", utilizados por el equipo de Bateson, son citados por primera vez en 1963 con relación a la familia y la enfermedad mental.

De aquí surge entonces que su modelo conceptual se base primero en las estructuras de conducta individuales (neuróticas) y en el sistema de comunicación aprendido en su modelo de socialización (puntos 1 al 5), para luego pasar al nivel del grupo familiar como sistema de comunicación que, al determinar situaciones recurrentes de comunicación, hace que el individuo se ubique de algún modo en dichas situaciones (punto 6), para dirigirse finalmente al contexto sociocultural en el que se inserta el grupo familiar que establece determinados tipos de comunicación según su clase social (punto 7).

Como se verá a continuación, este modelo pudo ser llevado a la práctica sólo en parte en los años subsiguientes. Sin embargo se observa muy tempranamente en Sluzki el interés por sistematizar al máximo posible las investigaciones de campo, aplicando a la psiquiatría el modelo empírico de las investigaciones en ciencias so-

ciales que Verón tomó de la sociología norteamericana a través de Germani.[38]

En este marco, el psiquiatra lanusino continuó desarrollando en sus investigaciones subsiguientes los tres niveles descriptos (individuo, familia y sociedad), para lo cual el Policlínico de Lanús seguía siendo un campo privilegiado. Allí se realizó la mayor parte del trabajo de campo donde, además de contar con el asesoramiento de Goldenberg y obtener subsidios de Conicet y del Foundations Fund for Research in Psychiatry, desde 1967 el proyecto formó parte del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella, del que Verón era director.[39]

La investigación iniciada en 1963 finalmente cobró forma de libro en 1970 con *Comunicación y neurosis*, escrito por Verón y Sluzki.[40] Ya en sus primeras páginas los autores aclaran que el proyecto "Es-

38. Gino Germani (1911-1979) creó la primera Carrera de Sociología (UBA) en la Argentina a mediados de la década de 1950, uno de los principales focos de debate político de los 60 alrededor de temáticas como la sociedad de masas, la democracia, el totalitarismo, el peronismo, el desarrollo, la modernización. Esta fundación generó un viraje de la sociología de las últimas cinco décadas pasando a la prevalencia de la tradición norteamericana. En este desplazamiento, la investigación sociológica cobró un perfil empírico y cuantitativo respecto del método, con un carácter fuertemente interdisciplinario. Ésta fue la "matriz institucional" del Instituto de Investigación, en el que trabajaba Verón, para el desarrollo de la investigación social. Tradujo a numerosos autores de la Escuela de Frankfurt y del psicoanálisis culturalista norteamericano (Blanco, 2006).

39. En este escenario, cabe tener en cuenta que tanto Goldenberg como Verón eran investigadores científicos del Conicet y que los subsidios fueron obtenidos a través del Centro de Investigaciones Psiquiátricas del Lanús. Esta situación remite a un fuerte debate instalado en el ámbito intelectual luego de 1955 respecto de aceptar ayuda económica de otros países, ya que el dinero recibido, fundamentalmente norteamericano, podría conllevar a mediano o largo plazo la sumisión de los desarrollos científicos y tecnológicos argentinos a los designios extranjeros. En este escenario, las ciencias sociales serían "el blanco preferido" de la lucha en contra de los subsidios (Sigal, 1991). Así y todo, tanto Germani, como Goldenberg, Verón y Sluzki no mostraron importantes reparos respecto del usufructo de las becas, promoviendo a través de múltiples medios, principalmente el Departamento de Sociología y el Lanús, su aparición. Este debate, sin embargo, cobró protagonismo en el Lanús cuando Hernán Kesselman rechazó en 1968 una beca de investigación norteamericana dirimiendo el conflicto con su renuncia al Servicio. Esta situación fue desarrollada por Carpintero y Vainer (2004).

40. El equipo de investigación publicó a nivel nacional e internacional diversos artículos previos a la edición de este volumen. Muchos se encuentran en *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, en los *Trabajos e Investigaciones del Instituto de Sociología* o la compilación de Verón en 1967: *Lenguaje y comunicación social*.

tructuras de conducta y sistema de comunicación social" iniciado en 1964 sólo pudo poner a prueba una parte de una de las siete proposiciones presentadas (la tercera).

Se puntualizarán aquí algunas cuestiones relativas al modo en que los autores conciben la articulación entre psiquiatría, neurosis, comunicación y familia. En principio, sostienen que "la expresión «enfermos mentales» es una categoría ideológica antes que científica" (Verón y Sluzki, 1970: 13). Así, el "enfermo mental" supone un rol definido socialmente, a partir de los mecanismos que cada sociedad moviliza para detectar conductas "anormales" y estimular a sus miembros al comportamiento "normal" que suponen sus obligaciones sociales. Así como el medio social define quién es un enfermo mental, establecerá en qué momento necesita ayuda del profesional. Pero además, la actitud hacia el trastorno mental y su "visibilidad" varían según la clase social. Las afirmaciones de Verón y Sluzki dejan claramente establecido que las designaciones médicas de las enfermedades mentales son hechos sociales (para lo que se basan, entre otros autores, en la *Historia de la locura* de Foucault publicado en 1961, referencia al movimiento estructuralista francés que el sociólogo argentino representaba en estas latitudes).

Esta vinculación entre las enfermedades mentales y el medio social va más allá de la constatación de la "influencia" de factores socioculturales para la identificación, el segregamiento y el tratamiento de los pacientes. De hecho, los autores afirman que "que el grupo familiar tiene que ver con la enfermedad mental es un corolario obligado del supuesto básico acerca del vínculo entre la personalidad y la sociedad […] Con todo, el panorama en este campo no es mucho más positivo que el que acabamos de describir en relación con los factores sociológicos generales, y los resultados obtenidos no parecen guardar proporción con la magnitud del esfuerzo, materializado en muchos centenares de trabajos" (Verón y Sluzki, 1970: 24). Basados en la revisión realizada por J.P. Spiegel y N.W. Bell (1959) sobre el estado de la investigación en el tema, concluyen:

> La mayor parte del trabajo conceptual, teórico y de investigación está aún por hacerse. […] El área del paciente psiquiátrico y su familia ha mostrado hasta el momento más promesas y menos resultados que casi cualquier otro segmento del trabajo psiquiátrico. (Verón y Sluzki, 1970: 25)

De cualquier modo, hay un acuerdo general respecto de considerar a la familia como una totalidad o sistema, con las investigaciones

centrándose en dos extremos: en los estudios epidemiológicos o ecológicos, por un lado, o en el estudio de los pacientes asociados a su grupo familiar, por el otro. Los enlaces intermedios, como la relación de la familia con su medio sociocultural, casi no fueron explorados.

Los autores centran su investigación en el individuo enfermo. Para ello, sostienen que la enfermedad será entendida como un fenómeno de comunicación, y el surgimiento de la neurosis, como efecto de determinadas condiciones sociales (Verón y Sluzki, 1970. 33). Lo que ellos observan es que, así como hay importantes obstáculos para la investigación a nivel social, los obstáculos para los niveles de la conducta individual y grupal se basan en un exceso de teorías, como las diversas orientaciones psicoanalíticas, conductistas, interaccionistas, funcionalistas, etc.; y en una fuerte desproporción entre la riqueza de estas teorías y la pobreza de instrumentos para describir las conductas que pueden corresponder a las entidades nosológicas psiquiátricas, o a la descripción de situaciones sociales y familiares que pueden presentar propiedades psicopatogénicas. Siguiendo esta idea, se basan en una larga lista de autores norteamericanos que abordaron los modelos comunicacionales,[41] que serán de suma utilidad para el esquema presentado en *Comunicación y neurosis*.

Asimismo, retomarán la teoría del doble vínculo como modelo formal de la interacción familiar. Esta situación contradictoria, que puede ser condición necesaria para una respuesta esquizofrénica, es una forma de organización de la interacción que puede materializarse en cualquier nivel socioeconómico. Lo importante allí será determinar el "modo de organización de la interacción", es decir, el "cómo" más que el "qué" de las transacciones.

El libro, por lo tanto, planteará la elaboración de un marco conceptual que se deriva de la teoría de la comunicación, del análisis e interpretación de los datos empíricos recogidos de pacientes neuróticos, y de la construcción de algunas técnicas. La neurosis aquí es considerada un sistema de técnicas de manipulación de los significados transmitidos en situaciones interpersonales, es decir, el neurótico tiende a crear situaciones interactivas que inducen en los demás respuestas que complementan sus propias conductas (p. 229). Asimismo, si se plantea que todo mensaje tiene dos caras, una que remite a la interacción y otra que remite a la "concepción del mundo", se puede afirmar que en una entrevista psiquiátrica "el paciente

41. Citan, entre otros, a Bateson, Haley, Jackson, Ruesch, Watzlawick y Beavin, y las investigaciones del grupo de Bateson (Verón y Sluzki, 1970: 36).

no sólo está hablando *de* su enfermedad, sino que además, *está hablando su enfermedad*" (233). A partir de estas bases, plantean las siguientes estructuras de conducta:

1. La neurosis histérica desde el esquema de Fairbairn presenta el objeto aceptado externo y el rechazado interno. Tiene una orientación positiva hacia un objeto del mundo exterior (lo sobrevalora) y una evaluación negativa de partes de sí mismo (lo desvaloriza). Aquí la dinámica básica entre actividad-pasividad plantea que el histérico intentará definir su rol como pasivo, sufriendo las consecuencias de los actos de los demás y quedando a merced de las circunstancias, expresado esto en el dramatismo histérico. Empero, a la vez, el histérico instrumenta inconscientemente sus estados para obtener cosas de los otros.

Ahora bien: ¿cómo es el proceso de aprendizaje y el modelo socializador que llevó a que el sujeto que aprende esta técnica internalice este sistema de codificación interactivo? La dinámica de aprendizaje familiar consistirá en una definición de la situación explícita, en la cual por una parte se castiga al sujeto cuando manifiesta iniciativas o conductas activas para obtener ciertos resultados y, por otra parte, se lo gratifica cuando manifiesta estados que resulten de la actividad de los agentes socializadores hacia el niño. Así, la actividad quedará asociada a la frustración y la pasividad a la gratificación. De esta manera, el único modo que tiene el niño para no violar las normas explícitas y responder al mismo tiempo a las exigencias implícitas es un cumplimiento indirecto de dichas exigencias bajo la forma permitida del modelo explícito, aprendiendo a instrumentar progresivamente sus propios estados para insertarse en la situación. Dicho de otro modo, en el caso de la neurosis histérica, la instrucción paradójica y contradictoria será: "aceptamos tus iniciativas a condición de que aprendas que está prohibido tener iniciativas". Por lo tanto, la adaptación histérica se basa en una incongruencia lógica: es miembro de dos clases cuyas normas explícitas son excluyentes. Lo esencial del despliegue histérico seductor es la "inocencia" o "ceguera" que lo acompaña. Esto podría traducirse en que el histérico niega a esas conductas su carácter de mensaje dirigido intencionalmente a otras personas, es decir, niega que los demás respondan a él por haber sido afectados por sus conductas. Así, lo que los otros perciben como exhibición es simplemente el modo de ser del histérico.

2. La modalidad fóbica ubica el objeto aceptado y rechazado en el ámbito externo, y plantea un temor al aislamiento y al encierro a

la vez. El problema básico del fóbico será discriminar entre las situaciones peligrosas y tranquilizadoras, por lo que tendrá un estado de alerta permanente para detectar estos indicadores. Pero para el fóbico el mundo nunca deja de ser potencialmente peligroso y, como la amenaza es constante, necesita asegurarse permanentemente la existencia de la protección. Así, en sus conductas evitativas hacia otro sujeto en el comienzo de un vínculo se recrea una especie de "puesta a prueba". Si el otro ignora que es amenazante, confirma la premisa general acerca del mundo del fóbico. Si en cambio el otro manifiesta una actitud tranquilizadora, está aceptando que algunas de sus conductas eran amenazadoras y con ello tranquiliza al sujeto fóbico. De este modo, permanentemente el fóbico confirma sus premisas sobre el mundo externo: del objeto amenazante que negó ser amenazante (concepción del mundo del fóbico) se aleja; del que aceptó estas premisas y lo tranquiliza se acerca, a condición de que sus creencias del mundo sean certificadas.

En el contexto de aprendizaje del fóbico se impulsa al sujeto a progresar por un intercambio relativamente autónomo con el mundo exterior, pero ese mundo es visto por los agentes socializadores lleno de peligros, un mundo amenazador. Esta última perspectiva metacomunica también que los agentes socializadores están exponiendo al sujeto a graves riesgos. Así, la visión implícita del mundo se acompaña de normas también implícitas que constituyen el modelo de "evitación instrumental" (Bateson, 1942), en el que "se prohíbe al sujeto correr riesgos y se lo gratifica cuando los evita" (Verón y Sluzki, 1970: 254). En consecuencia, esta configuración de mandatos plantea una incongruencia: el refuerzo explícito de la autonomía se contradice con la norma implícita de evitar los peligros, ya que por definición el mundo autónomo es peligroso. El sujeto fóbico sólo puede progresar hacia la autonomía protegido de los peligros por los padres, paradoja que puede sintetizarse como "sé autónomo dependiendo de mí".

3. La modalidad obsesiva ubica el objeto aceptado y rechazado en el ámbito interno, donde necesita a la vez expulsar y retener el objeto. Uno de los rasgos del obsesivo es utilizar las conductas "buenas" para evitar, neutralizar o controlar las "malas". Esto lleva en la ritualización a una especie de vaciamiento de sentido en la acción, ya que las conductas aceptadas no tienen un fin propio, sino que están en lugar de las acciones rechazadas, es "un mandato que enmascara una prohibición". Para el obsesivo, la gratificación consiste en evitar el castigo.

En este caso, se supone que los agentes socializadores presionan al sujeto para que se autonomice: si el niño quiere evitar el castigo, debe aprender a cumplir con su deber. De esta forma, el aprendizaje es definido como bueno o deseable pero sin gratificaciones instrumentales pues el niño no hizo más que cumplir con su deber. Ahora bien, si el niño hace cosas "malas" o deja de hacer las "cosas que debe hacer un niño", se lo castiga. Así, además de impulsar al niño a que asuma sus deberes como reglas para la autonomía, se le transmiten metamensajes de qué es intrínsecamente malo. La paradoja implícita aquí sería "sé autónomo aunque por supuesto eres incapaz de serlo".

Esta incongruencia poseería su punto de partida en la introducción prematura de ciertas disciplinas (en particular, se supone habitualmente las del control de esfínteres), en las que se imponen al sujeto exigencias desmedidas para sus capacidades actuales, fracasando necesariamente en su cumplimiento. El medio socializador no traducirá estos fracasos como inmadurez, sino como que el sujeto es "malo", conllevando al castigo por incumplimiento de las reglas. En este contexto, la familia se sitúa como mero intermediario entre el sujeto y las normas, por lo que el niño adscribirá formalmente a las normas, para evitar el castigo y la frustración; pero, a la vez, si hace algo mal, el metamensaje será "de él no podía esperarse otra cosa". De este modo, la seudosolución del obsesivo será cumplir con los dos aspectos de la contradicción: tenderá a realizar acciones formales en las que satisfará las exigencias de autonomía, pero estas actividades serán dedicadas a evitar sus propias acciones malas, que sería congruente con lo que los otros le transmiten de sí mismo.

En síntesis, en las tres modalidades la incongruencia en la organización de la situación de aprendizaje refuerza la respuesta neurótica como la mejor respuesta adaptativa posible a la contradicción "resolver el problema del pasaje a la autonomía sin resolverlo", donde "la fuente de este intento no es otra cosa que los conflictos neuróticos de los padres, combinados con el dilema del niño entre el impulso a independizarse de los padres y la necesidad de permanecer bajo su protección, de prolongar su dependencia infantil" (Verón y Sluzki, 1970: 265). El neurótico, más adelante, manipulará entonces la situación interactiva a partir de sus mensajes para verificar sus propias premisas acerca de la comunicación, a la par de autoafirmar sus creencias del mundo.

Reflexiones

Recapitulando, en función de los desarrollos de Sluzki y Verón, ya desde 1963 se observa un desplazamiento de los interrogantes alrededor de la relación entre familia y psicosis, para ampliarse a los de familia y neurosis. A la vez, es un modelo que incluye en su concepción de los desórdenes psiquiátricos individuales no sólo una etiología biológica y psicológica sino fundamentalmente una etiología basada en la interacción familiar.

La integración del modelo psicoanalítico de Fairbairn y la teoría de la comunicación norteamericana en una "teoría comunicacional de la neurosis" que funda sus cimientos en la familia, figura entre los aportes más originales de la historia de las ideas sobre psicoterapia familiar en la Argentina. La cristalización, como neurosis individual, de un conflicto transicional no resuelto en el seno familiar se asocia enteramente a los propios conflictos neuróticos de los agentes socializadores: los padres. Así como Sluzki y Verón ponen el acento en la perspectiva comunicacional explícita e implícita (que luego quedará subsumida en la idea de "sistema") para dar con la etiología de la enfermedad mental, Pichon-Rivière la conceptualiza desde la teoría de la enfermedad única (en la cual la familia en su carácter grupal interno y externo ocupa un lugar preponderante). En la misma línea, los profesionales posteriores trazarán diversos cruces entre psicoanálisis y ciencias sociales teniendo por eje a la familia. Para todos estos autores, el carácter implícito, latente o inconsciente, se da en un ámbito familiar que de una manera u otra incide en la configuración de la enfermedad mental. Más allá del modo en que entiendan su etiología y tratamiento, la familia será una de las principales puertas de entrada para la cura debido a su protagonismo en el punto de origen de la enfermedad.

Además, cierto uso implícito de un inconsciente vincular puede indagarse en los escritos de Sluzki, así como en el resto de los terapeutas familiares, aunque nunca fue teorizado por ellos. En este sentido, rastrear las consecuencias de un inconsciente relacional permite hacer pensable toda una zona de combinaciones teóricas, como la que se da en *Comunicación y neurosis* a partir de la neurosis de Fairbairn con el deuteroaprendizaje de Bateson, en la que ambas nociones presuponen ámbitos implícitos, latentes e inconscientes a nivel familiar.

Del mismo modo, el análisis que trazan Verón y Sluzki en ese volumen los pone en sintonía con otros modelos psicoanalíticos para pensar e intervenir en la familia. El cruce entre teoría de la

comunicación (que además de Bateson incluye a Saussure) con un psicoanálisis de corte inglés como el de Klein y Fairbairn, así como los aportes psicoanalíticos locales de Pichon-Rivière y Liberman, hace factible la idea de un inconsciente a nivel familiar que permite trazar el vínculo entre familia, neurosis y comunicación, así como el desplazamiento de la conflictiva edípica a la problemática de la autonomía, logrando así una de las síntesis más creativas en el área de la terapia familiar local. Sin embargo, la integración de estas ideas no perduró. Dichos desarrollos no han sido retomados ni por la corriente psicoanalítica ni por la sistémica. Esta última intentaba fervientemente desvincularse de cualquier residuo psicoanalítico, mientras que para el psicoanálisis local cada vez cobraba mayor fuerza un inconsciente entendido como estructura, a partir de la prevalencia de la lectura psicoanalítica estructuralista de Lacan.

La confluencia en sus orígenes entre la "estructura" y el "sistema" parece basarse más en los intereses de Verón que en los de Sluzki. Este último jamás cita a Lévi-Strauss o Saussure, sino que se apoya directamente en las citas a Verón, y más allá de *Comunicación y neurosis*, no se referirá a la "estructura", mientras que el "sistema" irá cobrando cada vez mayor protagonismo. Sin embargo, la incorporación de la teoría psicoanalítica de Fairbairn, así como la del cruce entre psicoanálisis y comunicación de Liberman, será obra de Sluzki a partir de su formación psiquiátrica y se ocupará de escribir el capítulo específico sobre "Comunicación y neurosis" que profundiza los aportes psicoanalíticos. Esta situación refleja un escenario de intereses diversos que se entrecruzan en *Comunicación y neurosis* tornándola una obra muy peculiar.

En pocas palabras, para los intereses sociológicos de Verón el atractivo residía en combinar estructuralismo y teoría de la comunicación, mientras que para las preocupaciones psiquiátricas de Sluzki el provecho radicaba en ensamblar teoría de la comunicación y psicoanálisis, cuestión que puede rastrearse en otros de sus artículos. De cualquier forma, la máxima integración de ambos corpus de ideas reside en las páginas del libro conjunto.

Ahora bien, si este volumen fue escrito por dos reconocidos intelectuales del campo de la sociología y las disciplinas *psi* que ya en 1970 tenían una amplia trayectoria nacional e internacional, ¿cómo se explica que el libro no fuera mayormente divulgado, citado, comentado y, mucho menos, reeditado? Aquí es donde, a partir del recorrido propuesto en el capítulo, pueden retomarse algunos de los puntos expuestos.

Por una parte, alrededor del campo intelectual, la modernización cultural de los 60 favoreció la expansión del psicoanálisis, la introducción del estructuralismo y la teoría de la comunicación humana, así como una amplia expansión de la industria editorial, en el marco del posperonismo y el desarrollismo de Frondizi. No obstante, la dictadura de Onganía cambió las reglas de juego a nivel político, repercutiendo de diversas maneras en el ámbito social y disciplinar. Respecto de lo que aquí se aborda, hay un desplazamiento geográfico de ambos autores. A partir de 1971 Verón se estableció en Francia y Sluzki en Estados Unidos, movimiento que coincidió con el desmembramiento del Servicio del Lanús, primer factor que podría haber incidido en la escasa difusión de la obra que sale a la luz en 1970.

Asimismo, las pujas en el campo disciplinar, fundamentalmente asociadas a la identidad profesional, pugnaban por separar teoría psicoanalítica y teoría sistémica, neurosis y comunicación, otro de los factores que podría haber incidido en el poco eco de estos desarrollos por parte de distintos profesionales.

Por último, a pesar de que los autores habían publicado en diversas editoriales (como se vio anteriormente pueden hallarse títulos en Nueva Visión, Eudeba, la Fundación Acta y Editorial Jorge Álvarez) será la Editorial del Instituto la que cobije en su catálogo el flamante volumen de *Comunicación y neurosis*. Una de las razones de la elección puede ser que el proyecto de investigación pasara a formar parte desde 1967 del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Di Tella para seguir continuando. Sin embargo, el Centro debió cerrar en 1970 por una conjunción de motivos económicos y políticos. Y, aunque la editorial continuó funcionando algunos años más, no parecían tiempos prósperos para su circulación.

Por tanto, aunque la investigación iniciada en 1963 y culminada en 1970 reúne una trama interdisciplinaria correctamente organizada, institucionalizada y financiada (de las escasas excepciones que pueden hallarse sobre las investigaciones locales en ciencias sociales del período), finalmente ocupa una posición paradójica. Por un lado, refleja las posibilidades que el campo intelectual facilitaba (fundamentalmente alrededor de las ciencias sociales y su cruce con las disciplinas *psi*); por otro, las imposibilidades de difundirse en un campo disciplinar que ya para inicios de los 70 volvía a dividir aguas entre ciertos psicoanálisis de corte ortodoxo (que se multiplicarían en esa década) y el resto.

En este punto, lo que fueron vientos favorables en un período se tornaron adversos en otro, dificultando en distintos niveles (personales, disciplinares, intelectuales, sociales y políticos) la transmisión de los

resultados del proyecto. El nombre de Verón quedó prácticamente exiliado del ámbito *psi*, y el de Sluzki con el correr de los años fue asociado a la teoría sistémica y a su rol de difusor de las ideas norteamericanas en la Argentina sin ninguna conexión con el psicoanálisis y la original trama teórico-clínica de *Comunicación y neurosis* que, en definitiva, quedará como una promesa del pasado no retomada prácticamente por ninguna de las vertientes que escriben sus páginas.

Bibliografía

Acuña, C. (2009), "La recepción del estructuralismo francés en el campo intelectual argentino de los años 50", disertación doctoral, Facultad de Psicología, uba.

Bateson, G. (1942), "Social planning and the concept of deutero-learning", en T.M. Newcomb y E.L. Hartley (eds.), *Readings in Social Psychology*, Nueva York, Holt (también en G. Bateson, "La planificación social y el concepto de deutero-aprendizaje", en *Pasos hacia una ecología de la mente*, Buenos Aires, Lohlé-Lumen, 1985).

–, D.D. Jackson, J. Haley y J. Weakland (1971), "Hacia una teoría de la esquizofrenia" (1956), en C. Sluzki (ed.), *Interacción familiar. Aportes fundamentales sobre teoría y técnica*, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo.

Bertrando, P. y D. Toffanetti (2004), *Historia de la terapia familiar. Los personajes y las ideas* (2000), Barcelona, Paidós.

Blanco, A. (2006), *Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo xxi.

Bleger, J. (1958), *Psicoanálisis y dialéctica materialista*, Buenos Aires, Paidós.

– (1963), *Psicología de la conducta*, Buenos Aires, Eudeba.

Bourdieu, P. (1994), "El campo científico" (1976), *Redes*, 2 (1), 131-160.

Carpintero, E. y A. Vainer (2004), *Las huellas de la memoria. Psicoanálisis y salud mental en la Argentina de los 60 y 70*, t. i: *1957-1969*, Buenos Aires, Topía.

– (2005), *Las huellas de la memoria. Psicoanálisis y salud mental en la Argentina de los 60 y 70*, t. ii: *1970-1983*, Buenos Aires, Topía.

Dagfal, A. (2009), *Entre París y Buenos Aires. La invención del psicólogo (1942-1966)*, Buenos Aires, Paidós.

De Sagastizábal, L. (1995), *La edición de libros en la Argentina*, Buenos Aires, Eudeba.

Dosse, F. (2004), *Historia del estructuralismo*, 2 vols., Madrid, Akal.

Fabris, F. (2007), *Pichon-Rivière. Un viajero de mil mundos*, Buenos Aires, Polemos.

Fairbarn, W. (1962), *Estudio psicoanalítico de la personalidad*, Buenos Aires, Hormé.

Fenichel, O. (1957), *Teoría psicoanalítica de la neurosis*, Buenos Aires, Nova.

GOLDENBERG, M. (1982), "Relato de mi más querida experiencia docente-asistencial", clase dictada en noviembre, en L. Hornstein, *Introducción al psicoanálisis*, Buenos Aires, Trieb.

LÉVI-STRAUSS, C. (1968), *Antropología estructural* (1958), Buenos Aires, Eudeba.

LIBERMAN, D. (1962), *La comunicación en terapéutica psicoanalítica*, Buenos Aires, Eudeba.

– (1976), *Comunicación y psicoanálisis*, Buenos Aires, Alex Editor.

MACCHIOLI, F. (2007), "La familia «freudo-pichoneana»", *Actas del VIII Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, Psicología y Psicoanálisis*. Recuperado de *http://www.elseminario.com.ar*

– (2010a), "Los inicios de la terapia familiar en la Argentina. Implantación, configuración y desarrollo de un nuevo campo disciplinar. 1960-1979", disertación doctoral, Facultad de Medicina, UBA-Conicet.

– (2010b), "El inconsciente vincular de Enrique Pichon-Rivière. Primeros desarrollos para el abordaje terapéutico familiar en la Argentina (1946-1977)", *Memorias de las XVII Jornadas de Investigación*, Facultad de Psicología, UBA, 365-367.

– (2010c), "Enrique Pichon-Rivière: la teoría de la enfermedad única a través de algunos de sus recorridos nosográficos", *ÁREA 3. Cuadernos de temas grupales e institucionales*, 14, 1-22. Recuperado de *http://www.area3.org.es/Uploads/ a3.14.TEU.FMacchioli.pdf*

–. (2010d), "Entre mitos y olvidos. Historia y epistemología de la terapia familiar argentina", *Actas del XI Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis*, vol. 11, 293-303.

– (2012a), "Terapia familiar y teoría de la comunicación humana", *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina. Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, 58 (3), 201-209.

– (2012b), "Inicios de la terapia familiar en la Argentina. 1960-1979", *Estudos e Pesquisas em Psicología*, 12 (1), Universidade do estado do Rio de Janeiro, mayo, 274-287 (también en *http://www.revispsi.uerj.br/v12n1/artigos/pdf/v12n1a16.pdf*)

– (e/p), "Enrique Pichon-Rivière y los saberes *psi* en la Argentina. Reflexiones sobre la conformación del vínculo entre la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología", *Psychologia Latina*, 4.

NOCETTI, J. C. (2002), *Familia y psicoanálisis en la Argentina. Apuntes para una historia conceptual*, Buenos Aires, Biblos.

PLOTKIN, M. (2003), *Freud en las pampas*, Buenos Aires, Sudamericana.

ROUGIER, M. y J. SCHVARZER (2006), *Las grandes empresas no mueren de pie. El (o)caso de Siam*, Buenos Aires, Norma.

RUESCH, J. (1957), *Disturbed Communication*, Nueva York, Norton.

SIGAL, S. (1991), *Intelectuales y poder en la década del 60*, Buenos Aires, Puntosur.

SLUZKI, C. (1973), "El enfoque interaccional como nueva perspectiva de la acción psiquiátrica", en W. Grimson (ed.), *Nuevas perspectivas en salud mental. Instituciones y problemas*, Buenos Aires, Nueva Visión.

– (1996), "Language, practices and record-keeping: A reflective consultation and some changes that resulted from it", *Human Systems*, 7 (2-3), 103-116.
– (1998), Prólogo, en *La red social: frontera de la práctica sistémica*, Barcelona, Gedisa.
– (2006), "Recordatorio del Dr. Mauricio Goldenberg (1916-2006)", *Psicoanálisis*, 28 (3), APDEBA, 472-473.
– y H. BLEICHMAR (1968), "El enfoque interaccional en terapia de parejas", *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, 14, 323-334 (también en C. Sluzki, ed., *Psicopatología y psicoterapia de la pareja*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1975).
TERÁN, O. (2008), *Historia de las ideas en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI.
VERÓN, E. (1963), "Notas para una concepción estructural en psiquiatría social", *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, 9 (4), 287-292.
– (1968), *Conducta, estructura y comunicación*, Buenos Aires, Jorge Álvarez Editor.
– (ed.) (1971), *Lenguaje y comunicación social*, Buenos Aires, Nueva Visión.
VERÓN, E. y C. SLUZKI (1970), *Comunicación y neurosis*, Buenos Aires, Editorial del Instituto.
VERÓN, E., A.L. KORNBLIT, R. MALFÉ y C. SLUZKI (1963), "Estructuras de conducta y sistemas de comunicación social. Un modelo conceptual para el estudio sociológico de las psiconeurosis", *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, 9 (4), 297-303.
VEZZETTI, H. (1996), *Las aventuras de Freud en el país de los argentinos. De José Ingenieros a Enrique Pichon-Rivière*, Buenos Aires, Paidós.
– (2002), "Enrique Pichon-Rivière, el vínculo y la Gestalt", *X Anuario de Investigaciones*, Facultad de Psicología, UBA, 443-449.
– (2004), "Los comienzos de la psicología como disciplina universitaria y profesional: debates, herencias y proyecciones sobre la sociedad", en F. Neiburg y M. Plotkin (eds.), *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina*, Buenos Aires, Paidós.
– (2007), "El psicoanálisis en el siglo", *Punto de Vista*, 88, 1-7.
– (2009), "Psicoanálisis y marxismo: la fractura de la Asociación Psicoanalítica Argentina (1971)", *Tempo Social*, (21) 2, 61-85.
VISACOVSKY, S. (2002), *El Lanús. Memoria y política en la construcción de una tradición psiquiátrica y psicoanalítica argentina*, Buenos Aires, Alianza.
WATZLAWICK, P., J. BEAVIN BAVELAS y D. JACKSON (1967), *Pragmatics of human communication*, Nueva York, W.W. Norton y Company (hay traducción: *Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías y paradojas*, Barcelona, Herder, 2002).
WOLFSON, M. (2009), *Mauricio Goldenberg. Una revolución en la salud mental*, Buenos Aires, Capital Intelectual.
ZITO LEMA, V. (1976), *Conversaciones con Enrique Pichon Rivière sobre el arte y la locura*, Buenos Aires, Ediciones Cinco.